

美和科技大學

護理系健康照護碩士班

碩士論文

探討血液透析護理師其工作壓力、情緒勞動與工
作滿意度之相關性

Investigating the relationship between job stress, emotional
labor, and job satisfaction in hemodialysis nurse.



研究生：吳欣芸

指導教授：韓彤珍 助理教授

中華民國 114 年 7 月

探討血液透析護理師其工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之相關性

Investigating the relationship between job stress, emotional labor, and job satisfaction in hemodialysis nurse.

研究生：吳欣芸

指導教授：韓彤珍 助理教授

美和科技大學

美和科技大學
護理系健康照護碩士班
碩士論文

A thesis submitted to the Department of Nursing of
Meiho University

In partial fulfillment of the requirement for the degree of

Master of Health Care
July 2025

學位論文

中華民國 114 年 7 月

美和學校
財團法人

美和科技大學

論文學位考試委員會審定書

本校護理系健康照護碩士班 吳欣芸 君

中文論文題目：探討血液透析護理師其工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之相關性

英文論文題目：Investigating the relationship between job stress, emotional labor, and job satisfaction in hemodialysis nurse.

業經本委員會評審認可合於碩士資格水準

論文學位考試委員會委員：

邱愛芳

楊榮

指導教授：

韓彤玲

系主任：

蔡玲君

中華民國 114 年 6 月 25 日

中文摘要

慢性腎臟病是一個嚴重的公共健康問題，台灣每年約增加 1.2 萬的洗腎人口，且全台洗腎人數已超過 9.7 萬人，然而，龐大的就醫需求，在護理人力不足的環境下，使得照護工作壓力越來越重，不僅影響病人的照護品質，也降低護理人員的工作滿意度，而其中血液透析護理師更被視為一種高情緒勞動的工作。本研究旨在探討血液透析護理師的工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之間的相關性，透過結構性問卷收集屏東市地區血液透析室之臨床護理師，採橫斷性調查，問卷內容包含基本人口學資料、工作壓力量表、情緒勞動量表及工作滿意度量表，採用 SPSS 26 版進行分析，利用描述性統計、獨立樣本 t 檢定、單因子變異數分析、事後檢定、皮爾森相關及多元線性迴歸，了解變項之間的相關性及預測因子。研究結果有效問卷為 124 份，發現不同的人口學變項對屏東市血液透析室護理師的工作壓力、情緒勞動及工作滿意度上有顯著差異，其研究結果為每周平均加班時數及任職醫院型態對工作壓力、情緒勞動及工作滿意度上有顯著相關，而是否為公職身分對工作壓力有顯著相關。再者，屏東市血液透析室護理師的工作壓力對情緒勞動有顯著正相關($r=.909$, $P<.01$)、工作壓力對工作滿意度有顯著負相關($r=-.846$, $P<.01$)、情緒勞動對工作滿意度有顯著負相關($r=-.835$, $P<.01$)以及每周平均加班時數 5 小時以上、工作壓力、情緒勞動為工作滿意度之重要預測因子，解釋變異量達總變異量的 74.2%，期許將研究成果提供透析室或醫院管理階層之參考，做為以後工作環境的改善及提供職場心理健康支持實證依據，進而提升其工作滿意度及護理服務品質。

關鍵詞：血液透析護理師、工作壓力、情緒勞動、工作滿意度

英文摘要

Chronic kidney disease (CKD) is a serious public health issue. In Taiwan, approximately 12,000 new dialysis patients are added each year, and the total number of dialysis patients has exceeded 97,000. However, this immense demand for medical care, coupled with a shortage of nursing manpower, has resulted in increasing caregiving pressure. This not only affects the quality of patient care but also reduces job satisfaction among nursing staff. Among them, hemodialysis nurses are particularly regarded as undertaking a high degree of emotional labor. The purpose of this study was to explore the relationships among job stress, emotional labor, and job satisfaction in hemodialysis nurses. A cross-sectional survey design was adopted, and structured questionnaires were administered to clinical nurses working in hemodialysis units in Pingtung City. The questionnaire included sections on demographic data, job stress scale, emotional labor scale, and job satisfaction scale. Data were analyzed using SPSS version 26.0, employing descriptive statistics, independent sample t-tests, one-way ANOVA with Scheffe analysis, Pearson correlation, and multiple linear regression to examine variable relationships and predictors. A total of 124 valid responses were collected. The findings revealed that demographic variables had significant differences in job stress, emotional labor, and job satisfaction among hemodialysis nurses in Pingtung City. Specifically, average weekly overtime hours and the type of hospital institution were significantly associated with job stress, emotional labor, and job satisfaction. Additionally, public employment status was significantly associated with job stress. Furthermore, job stress showed a strong positive correlation with emotional labor ($r = .909, p < .01$), and a significant negative correlation with job satisfaction ($r = -.846, p < .01$). Emotional labor also had a significant negative correlation with job satisfaction ($r = -.835, p < .01$). The key predictors of job satisfaction were working more than 5 hours of overtime per week, job stress, and emotional labor, which together explained 74.2% of the total variance. It is hoped that the results of this study can provide valuable reference for dialysis units and hospital administrators to improve working conditions and implement workplace mental health support, thereby enhancing job satisfaction and the quality of nursing care services.

Keywords : hemodialysis nurse, job stress, emotional labor, job satisfaction

誌謝

時光荏苒，兩年的碩士生活也將畫上句點，回想這段求學旅程，心中有滿滿的感激。從剛踏進教室選了個最後排的座位，一開始的緊張伴隨著一點點的期待，到逐漸適應研究所生活的節奏，每一段過程都彷彿歷歷在目。課堂上的絞盡腦汁、各種作業及論文的反覆修正、無數個夜深人靜的夜晚，坐在書桌前努力又痛苦的生出報告，這些點滴雖然充滿挑戰，卻也豐富了我人生的厚度，碩士生涯不僅提升了專業知識，更讓我學會思考、面對挫折的勇氣與拓展我護理職涯中前所未有的視野。我要衷心感謝我的指導教授-韓彤珍老師，感謝您在我寫論文過程中的指導與悉心教誨。不管是私下討論或是小組會議中，您總是以專業的角度，給予大家建議與方向，不吝分享經驗，老師的耐心與用心，是我在學術路上最重要的典範，另外也感謝兩位口試委員-愛芳老師與楊燦老師的建議，讓我的論文內容更加豐富，也更加奠定我學術研究的基礎。此外，也必須感謝一路相伴的同班同學們，大家都來自不同地方，每個人身上都有我值得學習之處，謝謝你們在課業與研究上的幫忙與分享，無論是討論題目、準備報告，或是彼此打氣，我們一起度過許多辛苦卻溫暖的時光。在兼顧工作與課業這忙碌又壓力沉重的日子裡，你們的陪伴讓這段旅程多了許多歡笑與力量，讓我求學的過程中不孤單，雖然只有短短的兩年，但這份同窗情誼，將成為我心中最珍貴的回憶。

最後，我要深切地感謝我的家人，感謝爸媽在我追求學業的路上，無條件的支持我，這兩年不間斷的接送我上下課，讓我沒有後顧之憂的專心於學業；也感謝我先生默默地承擔我無法兼顧的家庭責任，並且在我低潮、想放棄時給我鼓勵與幫忙。這份親情的支撐，是我能夠堅持到底、順利完成論文的最大動力，最後我要說：我畢業了！！

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
表目錄.....	vii
圖目錄.....	viii
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景及動機.....	1
第二節 研究目的.....	4
第三節 研究問題.....	5
第四節 名詞界定.....	6
第二章 文獻探討.....	8
第一節 血液透析護理人員及職業範疇.....	8
第二節 工作壓力.....	11
一、工作壓力之定義.....	11
二、血液透析護理人員之工作壓力.....	13
三、工作壓力之相關研究.....	16
第三節 情緒勞動.....	20
一、情緒勞動之定義.....	20
二、護理人員之情緒勞動.....	23
三、情緒勞動之相關研究.....	24
第四節 工作滿意度.....	28

一、工作滿意度之定義.....	28
二、護理人員之工作滿意度.....	29
三、工作滿意度之相關研究.....	30
第五節 工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之相關性.....	35
一、工作壓力與情緒勞動之相關性研究.....	35
二、情緒勞動與工作滿意度之相關性.....	36
三、工作壓力與工作滿意度之相關性.....	36
四、工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之相關性.....	38
第三章 研究方法.....	39
第一節 研究架構.....	39
第二節 研究假設.....	40
第三節 研究流程.....	41
第四節 研究設計.....	43
第五節 研究工具.....	44
第六節 研究場所及對象.....	47
第七節 資料處理與分析.....	48
第八節 研究倫理.....	49
第四章 研究結果.....	50
第一節 血液透析護理師之現況分析.....	50
一、血液透析護理師基本資料之現況.....	50
二、血液透析護理師工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之現況.....	54
第三節 血液透析護理師基本人口學與情緒勞動之差異分析.....	62
第四節 血液透析護理師基本人口學與工作滿意度之差異分析.....	67
第五節 血液透析護理師工作壓力、情緒勞動、工作滿意度之相關性分析...	72

第六節 血液透析護理師工作滿意度之預測因子分析.....	74
第五章 討論.....	76
第一節 血液透析護理師現況之討論.....	76
第二節 血液透析護理師基本人口學與工作壓力之差異討論.....	80
第三節 血液透析護理師基本人口學與情緒勞動之差異討論.....	82
第四節 血液透析護理師基本人口學與工作滿意度之差異討論.....	84
第五節 血液透析護理師工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之相關性討論...	86
第六節 探討血液透析護理師工作滿意度之預測因子討論.....	89
第六章 結論與建議.....	91
第一節 結論.....	91
第二節 研究限制.....	92
第三節 建議.....	94
參考文獻.....	96
附錄一 研究問卷授權使用書.....	111
附錄二 研究問卷.....	113
附錄三 人體試驗委員會同意書.....	120

表目錄

表 1 人口基本學資料分析.....	52
表 2 工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之現況分析.....	56
表 3 人口變項在工作壓力總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析	59
表 4 人口變項在情緒勞動總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析	64
表 5 人口變項在工作滿意度總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析	69
表 6 血液透析室護理人員工作壓力、情緒勞動與工作滿意度相關分析.....	73
表 7 血液透析室護理師工作滿意度之複迴歸分析.....	75



圖目錄

圖 1 研究架構.....	39
圖 2 研究流程.....	42



第一章 緒論

本研究為探討血液透析護理師其工作壓力與情緒勞動及工作滿意度之相關性，本章分為四節，第一節研究背景及動機，敘述目前研究的背景資訊及對研究領域的介紹，進一步說明研究者的動機，確定研究的基礎及意義；第二節研究目的，闡述研究的目標及意圖；第三節研究問題，提出問題加以驗證；第四節名詞界定，對本文中使用的名詞和概念進行明確和具體的解釋。

第一節 研究背景及動機

慢性腎臟病（Chronic kidney disease, CKD）在全球是一個嚴重的公共健康問題，影響著數百萬人的生活品質和健康狀況，根據世界衛生組織 2024 年的統計報告顯示腎臟疾病在 2021 年全球十大死因中排名第九名，在美洲及東地中海地區排名第七名，在高收入國家排名第九名，情況尤為嚴峻，推論隨著社會人口老化、城市經濟的進步以及生活方式的改變，慢性腎臟疾病在全球已是不可忽視的問題。根據美國腎臟數據系統(The United States Renal Data System，USRDS)2023 年最新統計報告指出 2021 年美國末期腎臟病罹病人數為 80 萬 8536 人，其盛行率為 0.22%，而台灣也面臨相同的問題，甚至為全國人民帶來更大威脅，在有接受治療的末期腎臟病患者發生率最高的 8 個國家中有 5 個位於亞洲，當中以台灣居

冠，為每百萬人口 522 人，其盛行率最高的國家排名第一同樣也是台灣為每百萬人口 3839 人，而透析是全球最主要的治療方式，2021 年美國有 11 萬 3309 名患者開始接受院所血液透析治療，佔發生末期腎臟病患者的 83.8%。根據健保署 2022 年統計，台灣每年約增加 1.2 萬的洗腎人口，且 2022 年全台洗腎人口已超過 9.7 萬人，密度居世界第一，故有「洗腎王國」的稱號，進而造成約 477 億元的洗腎醫療支出，由此可知腎臟健康對國人的影響及經濟帶來重大威脅。

然而，如此龐大的就醫需求及醫療環境的改變，使得護理人員的工作負擔越來越重，除了承擔著高壓力、工時長、輪班制度、薪資和福利不足等問題，還必須面對情緒耗竭、職業倦怠、染疫風險及低幸福感等心理變化，使得臨床上護理人才流失造成照護人力不足的惡性循環(黃素枝等，2021)。根據衛生福利部(2023)調查中發現 111 年度護理師空缺率 6.53%、離職率 11.73%，中華民國護理師護士公會全國聯合會 2024 年統計全國擁有護理師執照人數約 30.4 萬人，實際執業人數只有 18.9 萬人，執業率只有 62.2%，顯示職場就業率仍偏低，當缺乏臨床護理師，會影響病人的照護品質、醫院營運的效率及收入，間接影響護理人員的待遇及工作滿意度，故院方不得不重視及改善(張淑銘，2020)。

面對台灣血液透析市場近年來已達飽和，加上健保改革造成的收益減

少及同業間的競爭，大型醫院及診所各個提出自身優勢及額外服務，例如醫院可提供先進的設備和技術優勢，醫護人員有專業課程的培訓；診所則以更人性化的照護服務和便捷的地理位置吸引患者。而血液透析護理人員在每次為患者進行治療時，往往被視為一種服務而非專業，尤其洗腎是一個長期反覆的治療過程，多數患者已養成自身特有的習慣加上可能身心的不適，進而對醫療人員做過多的要求及態度不佳，使得血液透析護理師也被視為高情緒勞動的工作(楊舒雅，2024；詹佩蓉，2020)。

隨著洗腎人口的增加，血液透析護理師的角色也日益重要，多數文獻只針對一般護理師做探討，而針對血液透析護理師工作壓力、情緒勞動及工作滿意度三者之相關性進行探討的文獻較少，顯示出職場上的工作狀況並未受重視，有別於其他領域之護理人員，血液透析護理師與病人之治療關係更有其特殊性，護理人員之感受及面臨到的困難也有所差異，引發筆者想深入探究。因此，本研究由筆者所在位置的屏東地區做起，探討屏東市血液透析護理師之人口學特質、工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之間的相關性，並將研究成果提供透析室或醫院管理階層之參考，期許能夠改善護理師的工作條件及滿意度。

第二節 研究目的

本研究的目的是在於探討屏東市血液透析護理師其工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之相關性，透過問卷方式，蒐集屏東市醫院及診所血液透析護理師之工作感受，分析研究結果，供醫療院所提出的改善方案，提升護理人員工作福祉。研究目的為以下四點：

- 1.了解屏東市血液透析室護理師工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之現況。
- 2.了解屏東市血液透析室護理師人口學變項與工作壓力、情緒勞動及工作滿意度的關係。
- 3.分析屏東市血液透析室護理師在工作壓力、情緒勞動及工作滿意度的關聯性。
4. 探討影響屏東市血液透析室護理師人口學變項、工作壓力與情緒勞動對工作滿意度之預測因子

第三節 研究問題

根據上述的研究目的，歸納出本次具體的研究問題如下，以確立探討的重點及方向。

- 1.屏東市血液透析室護理師工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之現況情形為何？
- 2.不同的人口學變項在屏東市血液透析室護理師對於工作壓力、情緒勞動及工作滿意度相關性為何？
- 3.屏東市血液透析室護理師之工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之間相關性為何？
- 4.影響屏東市血液透析室護理師工作滿意度的重要預測因子為何？

第四節 名詞界定

一、血液透析護理師

概念性定義：擁有台灣護理師證書，通過血液透析訓練班筆試考試，在符合台灣腎臟醫學會認定之醫療院所實際操作血液透析技術並取得血液透析護理人員證書。

操作性定義：具有血液透析護理師執照且任職該機構工作滿 3 個月以上並實際參與血液透析臨床工作之護理師。

二、工作壓力

概念性定義：工作壓力的定義為因工作需求與自身能力、資源之間的差距而感受到的壓力，是一種個人心理感受和工作需求之間的不平衡狀態 (Latack & Havlovic, 1992)。

操作性定義：本研究使用蔡欣玲與陳梅麗於 1996 年發表之台灣護理人員工作壓力量表，共 47 題，以李克特量表(Likert Scale)九等級計分，分數 0-8 分，分數越高表示壓力越大。

三、情緒勞動

概念性定義：情緒勞動指為個人在工作中必須管理和表達特定情緒的過程，以符合組織或職業角色的期望。這種情緒通常抑制真實情感或展現並

不真實的情緒，以達成工作目標或滿足顧客需求(Hochschild, 1983)。

操作性定義：本研究使用林尚平於 2000 年發表之護理人員情緒勞動量表，共 24 題，以李克特量表(Likert Scale)七等級計分，分數 1-7 分，分數越高表示情緒勞動耗費心力越大。

四、工作滿意度

概念性定義：工作滿意度的定義為是一種心理狀態，反映了個體對於其工作經驗的整體感受和評價，這種感受涵蓋了對工作內容、工作環境、薪酬福利、人際關係，以及職業發展機會的滿足程度(Hoppock, 1935)。

操作性定義：本研究使用曾雯琦等人於 2017 年發表之護理人員工作滿意度量表，共 31 題，以李克特量表(Likert Scale)五等級計分，5 分代表「非常滿意」、4 分「滿意」、3 分「普通」、2 分「不滿意」、1 分「非常不滿意」。

第二章 文獻探討

本章文獻探討分為五節，第一節為介紹血液透析護理人員及職業範疇；第二節介紹工作壓力其定義及影響護理人員工作壓力及相關研究；第三節介紹情緒勞動其定義及影響護理人員情緒勞動及相關研究；第四節介紹工作滿意度其定義及影響護理人員工作滿意度及相關研究；第五節工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之間之相關性。

第一節 血液透析護理人員及職業範疇

末期腎臟病患者有兩種治療方法，一種為透析，另一種為腎臟移植，而透析又可分為血液透析（hemodialysis）及腹膜透析（peritoneal dialysis），血液透析護理人員是指執行血液透析專業技術之護理人員，利用病人的瘻管或雙腔導管將血液引至體外，藉由人工腎臟進行廢物及水份移除，再將以淨化的血液送回體內，俗稱「洗腎」或「洗血」（潘思宇、呂嘉薰，2024）。依據台灣腎臟醫學會(2024)訂定血液透析護理人員資格，須符合具備護士或護理師證照，並完成接受血液透析訓練班並通過筆試者，符合六年內在台灣腎臟醫學會認定之「血液透析護理人員訓練指定醫院」接受三個月(含)以上訓練或六年內在專任腎臟專科醫師主持之透析院所，該院所至少需有十五部血液透析機且每月透析人次至少 400 人次以上，並接受專職資深透析護理人員(持有血液透析護理人員證書，並有連續五年血

液透析臨床工作經驗)之訓練，且從事血液透析臨床工作連續六個月(含)以上。

血液透析護理師職業範疇，主要為照顧透析病患，負責上針或由其他血管通路接上洗腎機，依照醫囑設定之乾體重執行病患體內毒素與水分的清除，並記錄透析狀況，除了執行一般的治療工作外，護理師也需評估病人血管通路的變化，注意飲食控制、用藥情形及每次透析結束後返家的狀況，針對每個病患的問題做個別性的衛教及照護計畫，與醫療團隊共同討論病情，即時做治療上的調整，洗腎過程中，護理師需擁有較高的應變能力、警覺觀察力、謹慎評估病患，因腎臟科病人常伴有心肺功能等其他共病，須做到全人評估，照顧到身心靈方面，必要時協助透析過程給藥、驗血糖、抽血及輸血等護理技術，如有異常變化，需立即反應醫師以便及時處理，在治療時間外也須負責單位文書工作與環境維護(劉迅、范培金，2004；劉梅玉等，2012；林清戀等，2013；余鳳霞，2014)。

血液透析護理師同樣有輪班制度，為了滿足醫療機構的運作需求，確保病患能在 24 小時內隨時得到必要的醫療照護，可以保障醫療機構高效運作、提升病患照護質量。依據民國 109 年 6 月勞動基準法規定，輪班制係指工作地點及內容相同，僅工作時段不同且具有更換工作班別之情形，勞工工作採輪班制者，其工作班別，每週更換一次，但經勞工同意者不在

此限，依前項更換班別時，至少應有連續十一小時之休息時間，勞工連續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。根據許靖岱等(2013)文獻中，將護理人員排班分為兩類，一為輪班制，指 24 小時內更換班別，無論白班、小夜班及大夜班；二為固定班，指一年內固定上白班、小夜班及大夜班；另外若一週內同時輪值三種班別則為花花班。

血液透析護理人員班別可分為白班、小夜班。白班上班時間為 06：45 - 14：45、7：00 - 15：00、7：00 - 17:00、7:30 - 15:30、7:30 - 17:30、8:00 - 16:00、8:00 - 17:00、09：45 - 17：45、11:00 - 19:00；小夜班:14:00 - 22:00、14:30 - 22:25、15:00 - 23:00、16:00 - 00:00，無小夜班之工作日，則由白班人員加班至病人透析結束，有些醫療院所有特殊班別，例如大夜班:00:00 - 08:00 以及週日值班，需 24 小時待命，若有緊急需透析病人，則由值班護理師到院執行透析工作，以上輪班方式，應院所而異(張淑銘，2020)。

第二節 工作壓力

一、工作壓力之定義

將「工作」定義為 an activity, such as a job, that a person uses physical or mental effort to do, usually for money，意指一個人花費體力或腦力來完成的活動，通常是為金錢；「壓力」定義為 great worry caused by a difficult situation, or something that causes this condition，意指由於困難的情況或導致這種情況的原因而引起的巨大憂慮(Cambridge Dictionary,1999)。韋伯線上字典將「工作」定義為 to perform work or fulfill duties regularly for wages or salary，意指視為定期履行職責以獲得工資或薪水；「壓力」定義為 the burden of physical or mental distress，意指身體或精神上痛苦的負擔(Merriam-Webster,1996)。

國內外學者對工作壓力的定義為社會結構和角色對其個體產生的一種緊張狀態，當個體感知事件需求超過了其資源和本身應對能力所產生的一種心理和生理反應，會為個體帶來危機感而影響工作士氣(王怡璇、曾淑萍，2023；Lazarus & Folkman, 1984; Pearlin & Schooler, 1978)，壓力對個體的影響是多元的，會產生肥胖、高血壓、焦慮和憂鬱涉及生、心理各個層面(Pearlin & Schooler, 1978; Cox & Mackay, 1985; Latack & Havlovic, 1992; Valluri & Gorton, 2022)。

Karasek Jr (1979)主張基於「工作需求-控制模型」(Job Demand-Control Model)，將工作壓力定義為工作需求及工作控制之間的失衡，個體對工作的控制程度越高，足以應付工作需求帶來的生理及心理上的負擔，則工作壓力較低，強調了平衡工作需求和工作控制的重要性。Lazarus and Folkman (1984)提出壓力應對模型(Stress and Coping Model)，對壓力的評估分為兩階段，一為初級評估，是指個體評估情境本身帶來的損失與挑戰；二為次級評估，是指個體評估自身資源及能力後會造成的威脅程度，透過評估及應對的一個動態的互動過程進而達成平衡，若不平衡則可能產生壓力情緒(Latack & Havlovic, 1992)。

國內作者也提出對工作壓力的一些看法，李選 (1992)；陳柔安 (2020)及楊文杰 (2024)認為工作壓力是在工作環境中，所面臨的責任期望、人際關係、職業發展等對個人產生正向或負向的影響。當工作中遇到工作引起的刺激超出本身可承受的負荷會產生失望、煩躁、無力之感受(蔡豐任，2021)。職場中普遍的壓力源包括工作內容繁重、工時過長、職場環境不佳、職務角色衝突以及人際等因素，這些壓力源可能導致個體出現多種不良反應，並且可能進一步影響到工作表現和生產效率(岑俐玟，2024)。

工作壓力不僅是個體的感知和反應，它還深受社會結構和角色要求的影響，了解各方學者針對工作壓力的定義後，再深入探究護理人員的工作

壓力為何。

二、血液透析護理人員之工作壓力

在台灣的醫療體系中，護理人員不僅工作時間長和輪班制度，工作內容更是百百種，從專業的醫療照顧到協助病人日常起居，還要面對病人對照護品質的要求，護理人員常常需要在短時間內，有效率的完成大量的事務，使得護理人員不得不在高強度的工作環境中保持專注和耐心(林采怡、林弘昌，2019)。然而，工作壓力並不僅僅來自於繁重的工作量和高責任感，不定期支援其他專科病房、同事間的人際關係、感染風險高、過度勞累感、薪資待遇不平衡、額外負擔過多非護理職責的臨床業務以及因缺工造成休假天數過少等也是常見的一般護理人員工作壓力來源(Yang et al., 2017; 何玉菁等，2022)。

研究指出護理人員的工作壓力也會產生諸多影響，就工作方面會造成針扎、給藥錯誤、額外醫療成本增加及工作效率和品質下降；身體方面會造成肥胖、高血壓、高膽固醇、焦慮、易怒、憂鬱、精神不佳等狀況(Valluri & Gorton, 2022)。工作壓力與護理人員的藥物濫用率呈正相關(Ivey, 2015; Batalla et al., 2019)。此外，當工作壓力與個人壓力混合在一起時，護理人員自殺率的風險會增加五倍(Hooley et al., 2014; Quarshie et al., 2019)。

近年來，由於快節奏及需要高應變能力的工作環境，護理被視為高壓力的職業，特別是血液透析室的護理人員(Ling et al., 2020)。血液透析護理師在工作中面臨著許多特有的風險和壓力，這些壓力來源主要包括以下六個方面，一為血液感染風險，B 型肝炎 (HBV)、C 型肝炎 (HCV) 和人類免疫缺乏病毒 (HIV) 是 20 種血源性病原體裡最嚴重的(Saadeh et al., 2020)，透析過程中，護理師需進行瘻管穿刺、抽血、給藥、治療結束後拔針或不當處理針具所造成的針扎傷害是很常見的，這可能使人員受到疾病的感染(Amira & Awobusuyi, 2014)。二為複雜技術操作，血液透析室常規技術最困難處就是瘻管穿刺，有時因困難穿刺會影響到洗腎流程 (韓雲楷，2022)；血液透析機需要高度準確的技術操作，包括透析機參數的設定，如血液流速、脫水量、脫水速率、抗凝劑用量等以及監控透析過程中的各種指標，對於機器異常警報的處理與排除，需隨時做應變調整(曾玉華等，2021)，且現今市面上洗腎機廠牌多元，醫療院所購入不同型號的洗腎機，必須熟悉各個洗腎機器的面板操作，以免對病患造成嚴重後果。三為職業傷害，廣義的職業傷害原因很多，例如長時間不正確的行為、姿勢不良、過度用力、高重複性動作等都可能造成受傷(Wizner et al., 2021)，血液透析護理師經常需要長時間彎腰上針、進行重複性上機卸機動作，而搬運沉重的洗腎藥水，所造成護理師網球肘、媽媽手的問題出現也時常出現，迫使護理人員不得不離開職場(于劍興，2023)，更有文獻指出每兩名血液

透析護理師中就有一人有手部肌肉骨骼相關的疾病(Westergren et al., 2020)，而護理人員下背痛的發生率高達 88.9%，其血液透析室之盛行率位在所有護理單位中的前三名(柯惠文等，2011)。四為心理壓力，護理人員的心理壓力部分來自於照護的洗腎患者，當進入透析階段的慢性腎臟病患者，疾病狀況不可逆且可能會惡化，對於疾病的不確定性和漫長治療過程中的不適，會使患者有壓力、焦慮及憂鬱感受(Shokrpour et al., 2021)；再者，日常生活方面，護理人員需對患者做飲食、藥物、水份攝取等衛教，教導患者應遵照調整及改變，進行嚴格控制(Vr & Kaur Kang, 2022)，此外，每兩到三天往返醫院，每次固定治療數個小時，可能影響了患者的社交活動和家庭關係，由於身體狀況的限制，患者可能會感到自尊心受挫，自信心下降，這些對他們的心理都造成了負面影響(Shahrbabaki et al., 2023)，而以上這些負面情緒將可能轉嫁至護理人員身上，Hreńczuk (2021) 研究指出洗腎患者有 82%是需要護理人員富有同理心的，86%的洗腎患者覺得互信良好的護病關係是很重要的。病人越依賴血液透析室護理人員，希望獲得心理上的支持和滿足感，也為護理人員帶來了龐大的情感負擔(Hayes et al., 2015)。五為緊急應變能力，在透析過程中，血液透析護理師可能會遇到常見的急性併發症，包括透析中低血壓、高血壓、心律不整、抽筋、癲癇、心因性猝死、頭痛、管路凝血、透析器過敏反應等，約 10%~70%的洗腎患者都會發生這些併發症，面臨突發狀況時，護理師需迅

速做出反應和處理以預防患者死亡，也增加了血液透析室護理人員的工作壓力(Ponce et al., 2019; Saurav Singh & Pratima, 2023)。六為人際關係，由於洗腎患者每週固定時間至透析院所治療，使得護理人員長期與同一患者反覆接觸，有時長達數十年，而這種定期、持續且長時間的互動，使護病之間形成一種特殊關係，類似「準家庭式」情感連結，使護病關係的界線更加親密及模糊，雖能為患者提供心理支持但也為護理人員帶來情感負擔(Hayes et al., 2015)，反之，若人際關係差，護理人員可能必須承受來自病人或家屬的壓力，包括投訴、騷擾和其他冒犯(Ling et al., 2020)，同事之間的人際互動也被視為一種工作壓力來源，主因是由於工作量大、工作團隊間缺乏凝聚力且無同理心(Hayes et al., 2015)。

三、工作壓力之相關研究

研究指出工作壓力與護理人員的人口學屬性有顯著差異。陳美惠(2023)探討加護病房護理人員其工作壓力、休閒參與以及身心健康三者之間關連性和影響因素，研究結果發現子女人數與年收入在工作壓力有顯著差異。王藝蓁(2023)探討 COVID-19 專責醫院的護理人員工作壓力與自覺健康狀況及其影響因素，結果表示照護 COVID-19 病患的護理人員之年齡、教育程度、護理工作年資、上班工時與每週加班時數與工作壓力呈正相關；工作壓力與自覺健康狀況有顯著的低度正向相關。蔡沂好(2024)探

討不同人口學背景影響加護病房護理人員工作壓力的相關因素，結果表示扶養的子女數與工作壓力有較高的顯著影響。李昭婷 (2021)探討彰化縣國中小學校護理人員工作壓力會受不同年齡、子女數、教育程度、學校種類、學校規模、學校護理工作年資及職務類別影響，在工作壓力上都具顯著差異。Ali 等(2022)探討 COVID-19 爆發期間醫院護理人員工作壓力，結果發現工作壓力與工作量、性別、婚姻狀況、是否有子女、科別具有顯著相關，而女性、無結婚、40 歲以下、無孩子的護理師壓力程度顯著較高，工作年資 10 年以上的護理人員的平均壓力程度顯著較低。李正涼 (2022)探討屏東地區專科護理師專業能力與工作壓力之相關性，有效問卷 108 份，研究結果顯示整體的工作壓力感受程度為中度；年齡越輕、子女年紀較小、臨床工作年資、專師層級、薪資較低者，工作壓力感受越高，整體專業能力與整體工作壓力為負相關。

研究也發現護理人員的工作壓力來源有不同。陳淑純等 (2022)探討照顧 COVID-19 病人的護理人員在工作中的壓力和復原力，結果表示工作壓力前三名是害怕自己被感染、感控措施等相關資訊常常變動，適應不及、戴上防護裝備，視線受阻，而護理人員的教育程度、是否與家人同住對工作壓力皆有顯著相關性。許閔惠 (2022)透過量性問卷及質性訪談在新竹某醫院探討醫事護理人員之工作壓力、養生休閒與身心狀態之研究，發

現引起工作壓力最主要的前三大原因為工作量大，與家屬或病人的關係、額外負擔的業務。張偉斌等(2020)蒐集了 129 位公共衛生護理人員回收問卷，分析其工作壓力主要來自於主管緊急交辦的事項，常常需在週末出勤宣導活動，導致休假日無法好好休息，而有精神緊繃、身心疲倦感。陳淑貞等(2021)探討北區某醫院護理人員工作壓力來源前三名，分別為(1)同時照顧兩位瀕死病人，讓我非常的忙碌(2)當病人病情有變化或問題時，醫生遲遲不來，使我很有壓力(3)上夜班時，病人病情突然發生變化，使我感到壓力大。Ponce 等人(2019)探討血液透析過程中，護理人員所面臨的挑戰，結果發現隨著慢性腎臟病病人病況越來越嚴重和複雜，意味著需要更多的照顧及責任，護理師認為所負擔的工作量就越大以及對病人及家屬的知識衛教缺乏有系統、有計畫的持續給予，而家屬及病人對於接收訊息的程度與實行效果也有落差，這些困境皆構成了工作壓力。

在新冠肺炎爆發期間也有不少探討護理人員工作壓力之相關研究。

Yıldırım Keskin and Şentürk (2023)探討在 COVID-19 大流行期間血液透析護理師的經驗，多數護理師表示在 COVID-19 流行期間工作壓力來自於工作長，每週平均工時增加 10 小時、工作量及輪班頻率增加。Uvais 等人(2020)探討在 COVID-19 期間為醫療人員帶來的烙印及汙名化，醫院是新冠病毒污染的高風險區域，COVID-19 期間在醫院工作的醫護人員受到朋

友與家人的恥辱，研究顯示血液透析工作人員的恥辱感程度與工作壓力有顯著相關。Lee and Hwang (2024)探討 2022 年 COVID-19 流行期間韓國某醫院醫護人員的工作壓力，結果發現 COVID-19 爆發後工作量增加，工作壓力也越高，研究顯示年齡 20 幾歲的護理師感到工作壓力的頻率最高。

蔣凱若等(2022)探討國軍醫院急診護理人員之工作壓力與生活品質之關係，結果表示國軍醫院急診護理人員工作壓力是影響護理人員生活品質的重要預測因子，護理人員工作壓力每增加 1 分，其生活品質下降 0.13 分，代表工作壓力愈高，其生活品質愈差。Arnetz 等人 (2019)探討大型醫院護理人員工作環境對生物指標的影響，研究發現工作壓力與脫氫異雄酮硫酸鹽(DHEA-S)賀爾蒙的分泌呈負相關，而進一步影響護理人員的健康。

綜合以上研究可以發現護理人員工作壓力會受性別、年齡、教育程度、婚姻狀況、子女數、收入、年資、工時、科別等人口學屬性而影響，工作壓力來源以工作量大為主，工作壓力愈高，也會影響生活品質及賀爾蒙的分泌。

第三節 情緒勞動

一、情緒勞動之定義

情緒勞動(Emotional Labor)又可稱為情緒勞務(Hochschild,1983)，韋伯線上字典將「情緒」定義為 relating to emotion，意指與情感有關的；「勞動」為 an act or process to exert one's powers of body or mind，意指為發揮身體或精神的力量的行為或過程(Merriam-Webster,1996)。Dictionary.com 線上字典將「情緒勞動」定義為 the suppression of negative emotion and the assumption of a polite and cheerful facade at work，意指工作中抑制負面情緒並表現出禮貌和愉快的外表(Dictionary.com ,1995)。yahoo 線上字典將「情緒勞動」定義為要求員工在工作時展現某種特定情緒以達到該職位工作目標的勞動形式(Yahoo Dictionary,2001)。1983 年，美國社會學家 Arlie Russell Hochschild 其著作《The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling》中，首次提出情緒勞動的概念，以達美航空空服員為探討對象，他認為工作者透過偽裝真正的想法，表現出符合公司制度規範及顧客期望的樣貌。其他國內外學者也提出情緒勞動的定義是指處理他人感受的勞動，目的在於符合工作規則或組織監督下展現的或壓抑情緒，情感的表達也是一種勞動的形式，更視為一種商品，透過付出的情緒勞動可以達到銷售成功，情感的矛盾可以促進與他人良好的互動(劉佩均, 2020；于芄

盈，2021; James, 1989)

Wharton and Erickson (1993)將情緒勞動的定義細分為三種成份，一為工作者必須面對面或以聲音的方式與顧客接觸；二為在接觸顧客時，需產生一種情緒感受；三為工作者表現出來的情緒勞動受雇主的約束及規範。而情緒的表達包含三種，正面的情緒用於與顧客之間良好、愉悅的關係，例如空服員對乘客；而中立的情緒用於公正不偏袒，對任何一方不表明立場和行為，例如警察辦案；至於負面的情緒用來震懾、要求、敵對關係，例如債權人的催款。三種情緒的表現隨時會變動，若在工作中，需要頻繁的變化情緒表現，則對工作者的情緒負荷越沉重(林正士，2014)。

Morris and Feldman (1996)將情緒勞動定義為在人際交流的過程中，迎合組織規劃及顧客滿意的前提下，所努力表現出來的情緒，可分為四個構面，一為情緒表達的頻率，此為情緒勞動最重要的指標，當員工與顧客互動的程度越高，被要求情緒表現的頻率則越高，所感受到的情緒負荷也越重；二為情緒的關注程度，是指表現的情緒需要消耗多大的心力程度，此可分為持續時間和強度。當接觸顧客的時間越長，所需表現的情緒也越長，反之亦然，當面對顧客須要特定情緒表現的強度越強，例如強硬、遊說等態度，則員工則需耗費更多的注意力及偽裝，來維持展現出的情緒反應；三為情緒的多樣性，情緒表達有正面、中立、負面三種，當與人際互

動的過程中，須展現越多的樣貌，則感受到的情緒勞動越高(Wharton & Erickson, 1993)；四為情緒失調，指必須符合組織期望的但本身並未真正感受到的情感而強迫產生的情緒，若真實感受與表現落差越大，則情緒負荷越高(Glomb & Tews, 2004)。綜合上述，當情緒展現的頻率越高、人際接觸的時間及情感表現強度越強越多樣，則工作者的情緒勞動則越高。

Glomb and Tews (2004)提出情緒的三種表現，分別為真實情緒、虛假情緒以及壓抑情緒。真實情緒為內心真實感受到的與表現出來的情緒一致；虛假情緒為內心真實感受到的與表現出來的情緒不一致；壓抑情緒為內心真實感受到的未表現任何情緒出來。而虛假情緒及壓抑情緒發生時，才算是一種情緒勞動。

Hochschild(1983)情緒勞動分成兩方面一為表面演出（Surface Acting）指工作者壓抑自己真實的情感，僅在表面上表現出符合工作要求的情緒，內心並沒有真正得到相應的感受；二為深層演出（Deep Acting）是指工作者努力感同身受，改變內心的情緒，使自己的感受與所需的外在表現一致。兩種情緒表現的差異在於想像力，表面演出僅是為了迎合接受服務對象的感受，而掩飾出來的表現，而深層演出所具有的想像力是努力體會情境、換位思考，說服自己必須表裡如一的過程。

國內學者也提出對情緒勞動的一些看法，許劍橋 (2022)認為醫護人員

視病猶親、愛人如己就是一種隱形的情緒勞動，需透過學習而非天生，也需注意對方的感受適時調整；楊舒雅 (2024)認為情緒勞動的觀念與身體勞動一樣，在現今社會越來越被重視與受評值。

二、護理人員之情緒勞動

在醫療行業中，護理人員為典型的高情緒勞動工作者，身為第一線接觸病人及家屬的醫療人員，在照護過程中，除了治療身體上的疾病，往往也會成為病人及家屬情緒抒發的出口，護理人員也會被要求需要展現良好的態度及專業溫暖的形象，當病患在病痛中掙扎或家屬因病情焦慮時，護理師即使感到壓力或疲憊，仍需要提供情感安慰和心理支持，避免因自己的情緒而影響照護品質(于芍盈，2021)。而血液透析護理人員更是如此，血液透析護理師需要扮演很多角色，如護理技術者、護理照顧者、教育者、協調者和情緒諮詢者，他們必須整合這些角色，以便與每位洗腎患者建立特定的治療關係，確保達成病人的需求並在治療期間能提供優質、熱情和有效率的服務(Ponce et al., 2019)。另因為治療的獨特性，與病人接觸的時間，可從首次透析至人生的終點，這個過程往往長達數年，病人及家屬對於血液透析護理人員的依賴及要求更加明顯(楊舒雅，2024)。由於病患接受血液透析治療的年資長達數十年以上的比比皆是，很多腎友已養成自身特有的習慣，比如穿刺的位置、角度、順序及治療過程中種種的要

求，若無法達成期待，任憑護理人員表現得再好，也會造成護病關係間的不信任感，而長期面對洗腎患者負面的能量、病情變化的嚴重與複雜性及透析過程所發生的合併症，加上社會民眾對於血液透析工作的高要求，血液透析護理師被訓練學會自我調適，擁有強大的適應能力及心理素質，忍耐力及自我控制力，並對外展現一種大愛、包容、樂觀、開朗的心態，提高自身對負向情緒的應對能力，使得血液透析護理人員被視為高情緒勞動的工作(黃秋鵬等，2010；詹佩蓉，2020)。

三、情緒勞動之相關研究

研究指出情緒勞動與護理人員的人口學屬性有顯著差異，黃壬屏(2010)探討情緒勞動、幽默感與工作倦怠之關係，研究中以 549 位臨床護理人員為收案對象，研究結果顯示護理人員的情緒勞動偏高，護理年資 7-11 年者整體情緒勞動顯著大於 3 年以下以及 11 年以上的護理人員，急診單位的情緒勞動程度比其他單位來的大。于芍盈(2021)探討護理人員的情緒勞務研究，共有 312 份有效問卷，結果發現專業權力知覺與情緒勞動呈顯著正相關，意指護理人員對於自身的專業知識與經驗越多時，會感到越重的情緒勞動，而情緒勞動也受婚姻及年資影響，有婚姻關係及年資越深，有較高的情緒勞動。黃彩珍 (2023)探討台南市公衛護理人員情緒勞動、公共服務動機及職業倦怠的現況及關連性，共有 244 份有效問卷，研

究結果發現情緒勞動對職業倦怠呈正向顯著效果，而年齡、教育程度、工作場域、是否擔任主管職及遇到不理性民眾的頻率對情緒勞動方面都具有顯著差異。李敏瑤 (2023)探討護理人員之情緒勞動、職業倦怠對離職傾向差異與影響，共有 238 份有效問卷，結果發現工作年資和情緒勞動之情緒表達呈負相關，護理師所需的情緒勞動負擔顯著高於專師，性別及工作單位在情緒勞動有顯著差異。

Na and Park (2019)以首爾兩間醫院共 227 名護理人員為研究對象，研究結果表示情緒勞動中的表面演出顯著增加了情緒耗竭並降低了個人成就感，然而深度演出顯著提高了個人成就感。情緒勞動對離職有間接影響傾向，職業倦怠在情緒勞動與離職意圖之間的中介作用顯著，護理人員在護理工作情境中無法如實表達自己的情緒，在隱瞞或欺騙的過程中陷入情緒耗竭的境地，導致護理人員的情緒負荷增加，最終將迫使護理人員開始考慮離開這種疲憊的環境，萌生換工作的意圖。Gou 等人 (2022)以中國三間醫院共 496 名護理人員為研究對象，發現對於工作場所的排斥與情緒勞動的表面演出及深層演出具有正相關進而影響離職意願。

陳柵君等 (2021)探討負面事件對醫護人員情緒勞動及行為影響，回收有效樣本 327 份，研究結果表示負面事件會影響深層演出、深層演出會影響離職傾向及服務努力；表面演出對服務破壞有顯著的影響，此研究也

提出負面事件對護理師情緒和行為間接經由情緒勞動影響。負面事件又可稱為醫療職場暴力，包含語言、心理、肢體、性騷擾等；服務努力為一種能讓顧客與服務人員服務接觸時觀察到，且會影響服務結果之過程；服務破壞為員工有知覺的行動，該行動將負面地影響到服務傳遞，使服務未達水準。

胡曉玲等(2021)分析護理人員工作所面臨情緒勞動，透過質性研究對20位護理人員做深度訪談，以實際經驗來了解，研究結果產生情緒勞動可能原因分為三方面，一為經驗，面對病人不合理的要求、自身情緒控管能力不佳或被要求扮演稱職的護理角色，而感到沉重壓力；二為認知，面對千奇百怪要求時，常面臨職業角色的混淆，產生「護理專業是服務業嗎？」的困惑；當護理人員產生情緒勞動時，藉由資深人員臨床提點，接納承擔病人負面情緒其實是為工作的一部分；三為社會印象，社會對護理人員的印象為有愛心、耐心及具有同理心的照顧者，故為了符合社會期待，護理人員被迫主動展現正向情緒，迎合臨床情境氛圍，當面臨情緒勞動感受時，必須壓抑負向情緒，隱藏自我內心感受，用麻痺自我感受來面對。

曾俊維、顏芳姿 (2024)的研究中透過觀察與深度訪談在 covid-19 疫情間支援制度的轉變及投入支援勞動的護理師其情緒負擔，結果觀察到支援者跨單位調動在身份認同上或是與主管間協調換班的互動時，經常出現情

緒負擔的情形，但有趣的是因為 covid-19 疫情及支援制度，使得工作中必須穿戴口罩及防護衣，讓情緒的傳遞出現隔閡，使情緒勞動的負擔得以減少，且支援其他科別跳脫原單位組織制度，讓原本學長姐階級地位模糊而難以維持，也大大減輕護理師的情緒勞動負擔。

綜合以上研究可以發現護理人員情緒勞動會受年紀、教育程度、婚姻、年資、科別、使否輪班、職位等人口學屬性而影響，而大部分的研究也指出情緒勞動越高，會導致離職傾向。



第四節 工作滿意度

一、工作滿意度之定義

朗文當代高級辭典將「滿意」定義為 a feeling of happiness or pleasure，意指一種開心愉悅的感受(朗文當代高級辭典，2000)；劍橋線上字典將「工作滿意度」定義為 you experience in your job when you know that your work is worth doing, or the degree to which your work gives you this feeling，意指在工作中體驗到愉悅感和成就感的程度(Cambridge Dictionary,1999)；Dictionary.com 線上字典將「工作滿意度」定義為 the extent to which a person's hopes, desires, and expectations about the employment he is engaged in are fulfilled 意指一個人對其所從事的工作的希望、願望和期望得到滿足的程度。(Dictionary.com , 1995)。工作滿意度最早的概念源自於《The Human Problems of an Industrial Civilization》一書，1927 年至 1932 年間 Elton Mayo 美國一間電器公司工廠所進行的霍桑實驗，研究發現工作條件的改變和工作效率之間無直接關係，注重員工的情緒並給予管道抒發反而可有效提高生產效率。Hoppock(1935)其著作中首次提出對工作滿意度的定義，認為是員工生理與心理上對工作環境與工作內容所產生的主觀感受，並且工作滿意度受職業階級影響，而越高的滿意度，越能促使員工作出符合組織的期待。林効賢 (2020)、陳玄康 and 何

高志 (2023)認為工作滿意度是指工作當下生理及心理主觀感知，與最初對工作想像中的情境做比較，當工作感知超過期望，則滿意度越高，反之，滿意度越低(Smith et al., 1969)，滿意度會直接影響到員工的工作動力及績效，提升滿意度便能提高工作成效。另外宋佩佳 (2018)認為工作滿意度是指個人在進行工作的過程中，對工作相關的事物，例如內容、環境、壓力、方式、挑戰性和人際關係等一切與工作有關之感受的心理狀態。趙子揚、陸偉明 (2019)認為人們評價工作向度分為兩個，一為內在特質、二為外在特質，前者例如薪資待遇、晉升制度、工作條件、工作時間及員工福利等，後者為人際關係與社會評價等，當這些向度為員工帶來正向愉快的情緒則有較高的工作滿意度，工作本身的核心價值也連帶影響員工的工作意義、責任心與知識。

綜合上述，工作滿意度是員工對工作內容、環境、人際關係等的主觀感受，且滿意度與工作動力和績效直接相關。

二、護理人員之工作滿意度

護理工作滿意度是指護理人員對其工作能力、工作環境、醫院制度及報酬等方面的感受，與實際情況之間所感知的差距，這種滿意度受個人價值觀的影響，反映了護理人員對各方面的主觀認知以及對於是否受到公平對待的感受(Siqueira & Kurcgant, 2012)。由於近年來服務意識抬頭，民眾

對於醫療品質要求越來越高，漸漸出現職場不文明的行為 (Workplace Incivility Behavior)，意指他人不經意的行為造成對方不舒服之感受，在醫療環境更是明顯，面對病患或家屬無理的要求，雖不如職場暴力來的直接，但這種困擾無時無刻出現在日常工作中，使工作者熱情逐漸消磨殆盡，降低工作滿意度(高月慈等，2024)。再者，超高齡化社會來臨，對於護理照顧的需求增加，且台灣健保制度的改革和沉重醫療設備的成本，迫使醫院減少醫療人力及報酬支出，種種因素使得臨床護理人員留不住，新進人員訓練不足提早上線，工作負荷增加，進而影響病人安全問題及護理人員健康狀況及工作滿意度(陳淑貞等，2021)。

護理人員工作滿意更被認為是全球性問題，在西班牙超過 50% 的急診護理人員對工作不滿意，其導致的身心狀況如頭痛、憂鬱和失眠，據統計，每年因工作對護理人員造成的心理和生理疾病之醫療成本約 1.5 至 3.72 億歐元(Portero de la Cruz et al., 2020)。使得護理人員對本身的工作滿意程度不容忽視。

三、工作滿意度之相關研究

研究指出工作滿意度與護理人員的人口學屬性有顯著差異，Teruya 等人(2019)探討巴西醫院加護病房護理師的工作滿意度，共有 163 份有效問卷，結果發現對管理、同事、工作性質感到滿意，對報酬、薪資、福利、

作業流程、升遷等不滿意，而年齡、性別、職業類別、班別和加護病房科別與工作滿意度相關；年資越短，留在工作崗位的意願越大，工作滿意度越高。許惠菁 (2020)探討南部區域教學醫院護理人員個人屬性資料、工作滿意度與離職傾向之關係，共有 251 份有效問卷，結果發現性別、工作身分、教育程度與工作滿意度相關，又以男性、公職身分之護理師及研究所學歷有較高的工作滿意，原因為教育程度越高者，越有機會受醫院栽培及重視，而有較大的機會升遷，取得更好的工作職位及成就感，護理人員的工作滿意度總分與離職傾向呈現顯著負相關。蔡美曰 (2023)探討中部某區域教學醫院的臨床護理人員工作策略、自我效能與及工作滿意度的相關性，共有 404 份有效問卷，結果發現功能性單位人員，如門診、衛教中心、出院準備、居家服務之工作滿意度會高於急重症單位及一般病房；工作策略、自我效能和工作滿意度三者間呈正相關，工作滿意度越高的護理人員，其工作策略運用也越多，自我效能感高的護理人員也會提升工作滿意度感受；在人口學方面，女性、護理階級 N3 者工作滿意度得分最高，年齡與工作滿意度有顯著正相關。

綜合研究可以發現護理人員工作滿意度會受性別、職業身份、教育程度、護理進階層級、年齡、年資、輪班狀況、靈性健康、薪資等人口學屬性而影響(黃聖芳，2024；李月麗等，2021；Lu et al., 2019)，而大部分的

研究也指出工作滿意度越高，離職傾向越低，職場疲勞與工作滿意度呈負相關(許惠菁，2020; 陳冬蜜，2021)。

黃守智 (2018)探討血液透析機構護理人員組織氣氛、工作滿意度與留任意願之相關性，共有 45 份有效問卷及 5 位深度訪談，結果發現組織氣氛與護理工作滿意度之間具有正相關，工作滿意度與留任意願也具有正相關，而關聯性達顯著，主管的支持是工作滿意度的關鍵，一個受人喜愛的護理長會協助單位同仁處理狀況、負責教育工作，以身作則凝聚團隊氣氛。呂佳芬 (2023)研究北部某醫院護理人員輪調壓力與工作滿意之相關性，共有 114 份有效問卷，發現對於輪調訓練的認知和意願會影響輪調感受，兩者也與工作滿意有中度正相關。Bragadóttir 等(2023)對冰島醫院內外科加護病房護理師進行調查，共有 567 份有效問卷，發現有工作經驗者及單位內人力充足有助於提升工作滿意度，並且一個有良好團隊合作的單位，能使單位內工作人員提升五倍的工作滿意度；在這個護理人員短缺的大環境中，加強護理團隊合作有助於提高工作滿意度，能防止護理人員流失。Serra 等(2023)針對工作滿意利用系統性文獻回顧搜尋義大利母語及本國出版之研究，符合篩選標準有 8 篇文獻納入分析，結果發現大部分的護理師對組織福利、薪資報酬、工作自主權不滿意，若加上工作量大、主管的不支持、人力缺乏、認同感不足，則會加重不滿程度，文獻中指出有

20-40%的新進護理人員在第一年內離職，雖然認同護理工作能幫助他人獲得滿足與自信，但長時間的輪班制度、疲勞、繁重的工作量、與工作團隊或病人的關係等多重問題，迫使護理人員拉回現實層面，引起對工作整體的不滿意及厭倦感，正視護理工作所面臨的種種現況進行改善及優化是目前很重要的事。

Jakobsson Larsson 等人(2024)透過質性訪談 16 名在瑞典療養院工作的護理師，哪些正向經驗可提升工作滿意度，一為工作的意義，有能力幫助社會，喜歡並欣賞自己的工作，認為工作具挑戰性且多樣化，與居民及家屬互動相處中獲得歸屬感；二為具有自主權，有能力及知識處理護理工作，自己可主導工作分配；三為日常挑戰與專業發展的可能性，臨床工作涉及許多層面，透過機會不斷學習及注重個人的發展，有穩固的基礎得以面對挑戰；四為主管的支持，主管的領導及管理能力的被認為是工作滿意度最重要的部分，優秀的主管會給予關心及正面的回饋，當工作太過繁重，主管能重視且積極採取行動，減少其工作量；五為護理團隊的互助合作，做好自己的份內的事情，不將工作遺留給下一班的同事接手，遇到困難大家可以互相討論和學習，當感到疲累時，彼此可互相加油打氣，團隊中的氣氛融洽；六為對工作充滿信心，隨著年資的增長所累積的知識和經驗，護理師能夠熱衷的運用自己的能力，處理突發事件，與護理團隊一起解決

臨床上的問題並且協助減輕需要幫助的同事的壓力。



第五節 工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之相關性

一、工作壓力與情緒勞動之相關性研究

詹佩蓉等(2020)探討血液透析護理人員情緒勞動、工作壓力與生活品質三者間之關係，以中部地區血液透析護理人員為研究對象，有效問卷共有 204 份，結果發現在情緒勞動、工作壓力皆屬中上程度，分別以「克制負向情緒」耗費心力最大、「個人反應感受」之工作壓力的程度最高，整體而言，血液透析護理人員情緒勞動對工作壓力具有顯著預測力和正向影響。Sohn 等人(2018)探討韓國首爾一家綜合醫院之工作人員情緒勞動與工作壓力的關係，有效問卷為 461 份，結果發現臨床工作者比非臨床工作者表現出更嚴重的工作壓力，且持續時間明顯更長，強度更大，情緒勞動之表面演出水平更高；臨床工作者的表面演出與工作壓力呈現顯著正相關，而深層演出與工作壓力則無顯著相關性，中介分析中對於臨床工作者，表面演出與工作壓力的增加有直接相關，與憂鬱有間接相關。詹雯月(2021)探討護理人員情緒勞動、工作壓力與生活品質關係之研究，研究結果發現教育程度在情緒勞動因素上達顯著差異性，工作單位在工作壓力、情緒勞動達顯著差異，而護理人員的工作壓力與情緒勞動呈中度正相關。何玉菁等(2022)探討護理人員工作壓力、情緒勞動、情緒智力現況與留任意願之間的關係，共有 559 份有效問卷，結果發現在內科和外科服務的護

理人員，其工作壓力及情緒勞動偏高；年輕、未婚、輪班或固定排大、小夜班的護理人員，其工作壓力偏高；情緒勞動會影響護理人員的工作壓力，而工作壓力則會影響護理人員的留任意願。

二、情緒勞動與工作滿意度之相關性

王靖儒 (2020)探討臨床護理師自我效能、情緒勞務及工作滿意度之相關性，有效問卷 152 份，結果顯示情緒勞務對工作滿意度呈正相關，婚姻狀況在工作滿意度上有顯著性的差異，且已婚者高於未婚。陳雅玲 (2024)探討情緒勞務、工作倦怠、工作滿意度對離職傾向的影響關係，以南部地區醫院執業護理師為研究對象，利用 google 表單回收有效問卷共 400 份，結果發現護理人員情緒勞務與工作滿意度呈負向顯著影響，且情緒勞務的負面影響透過工作倦怠和工作滿意度中介效果會加重護理人員的離職念頭。Xu and Fan (2023)研究檢驗中國護理師護病關係在情緒勞動與工作滿意度之間的中介效果，回收有效問卷共 620 份，結果發現表面演出會對工作滿意度產生負向影響，而深層演出對工作滿意度產生正向影響；護病信任和以病人為中心的照護在情緒勞動和工作滿意度關係中的平行中介作用具有統計意義。

三、工作壓力與工作滿意度之相關性

林采怡、林弘昌 (2019)探討某區域教學醫院臨床護理人員在工作時所

感受到的工作壓力與自我效能對工作滿意程度之影響，回收有效問卷共 207 份，結果發現不同年齡層護理人員的工作壓力達顯著差異、不同服務單位的護理人員的工作滿意度達顯著差異、工作壓力與工作滿意度呈現顯著負向相關。黃聖芳 (2024)探討中部某區域醫院護理人員工作壓力、社會支持與工作滿意度之相關研究，回收有效問卷共 200 份，結果發現工作壓力與工作滿意度平均數為中等略高程度，年齡、教育程度、婚姻狀況、子女數、任職單位、薪資、年資、與護理人員的工作壓力與工作滿意度達顯著差異；工作壓力與工作滿意度呈顯著負相關；工作壓力對工作滿意度具顯著預測力，其中工作壓力的勝任工作對工作滿意度的負向預測力最高。AbuAlRub 等(2023)探討阿曼 11 間醫院 1796 名臨床護理人員的工作環境、工作壓力和工作滿意度之間的關係，結果發現感到工作壓力較高的護理人員的滿意度較低，並且認為他們的工作環境較不利和缺乏支持性；也顯示了實施賦予員工權力、提供支持性和積極的工作環境以及解決工作壓力對提高工作滿意度水平是重要的。Çivilidağ 等人 (2024)探討在 COVID-19 流行期間第一線醫護人員的工作滿意度、工作壓力和倦怠程度，透過系統性文獻回顧，分析了 13 個國家 54 篇文獻共 49139 名樣本數，結果發現工作壓力與工作滿意度之間存在負向低顯著相關，在漫長的疫情期間，由於嚴格的隔離措施、加班制度、疲勞、失眠以及對病毒傳播的擔憂，醫護人員經歷了更多的工作倦怠，而緊張的工作步調、衛生設備的不足、病患死亡

和低薪是工作滿意度降低、工作壓力上升的主因。

四、工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之相關性

Wu 人(2018)探討中國護理人員的工作滿意度、情緒勞動、核心能力和工作壓力的現狀以及情緒勞動和核心能力與工作滿意度的關係，蒐集了 92 間醫院共 11337 份有效問卷，調查結果顯示華人護理人員的工作壓力中度等級，情緒勞動中高度等級，工作滿意度普通。在多元線性迴歸顯示，工作壓力與工作滿意度呈負相關；情緒勞動中的表面演出與工作滿意度呈負相關；深層演出和工作滿意度呈正相關。此外，在工作壓力、醫院地理位置、醫院類別、性別、輪班、本身是否為獨子、是否有子女、月薪、年資、職別、科別是工作滿意度的影響因素。

目前缺乏探討血液透析護理師其工作壓力、情緒勞動與工作滿意度相關性之研究，但根據上述眾多文獻參考，可以約略了解三者之間相關性，研究者根據自身工作經驗及文獻閱讀進行此方面之研究假設，選擇探討屏東市血液透析護理人員其三者之間的關係，填補現有文獻的空缺，並對未來地方政府發展提供參考。

第三章 研究方法

本研究探討屏東市血液透析護理師其工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之相關性為主題，依據研究目的制定研究方法，本章分八節，第一節為研究架構，第二節為研究假設，第三節為研究流程，第四節為研究設計，第五節為研究工具、第六節為研究場所及對象，第七節為資料處理與分析，第八節為研究倫理，第九節為預期成效，茲分述如下：

第一節 研究架構

依據本研究目的及問題，擬定研究假設，提出研究的架構圖，如下圖

1。

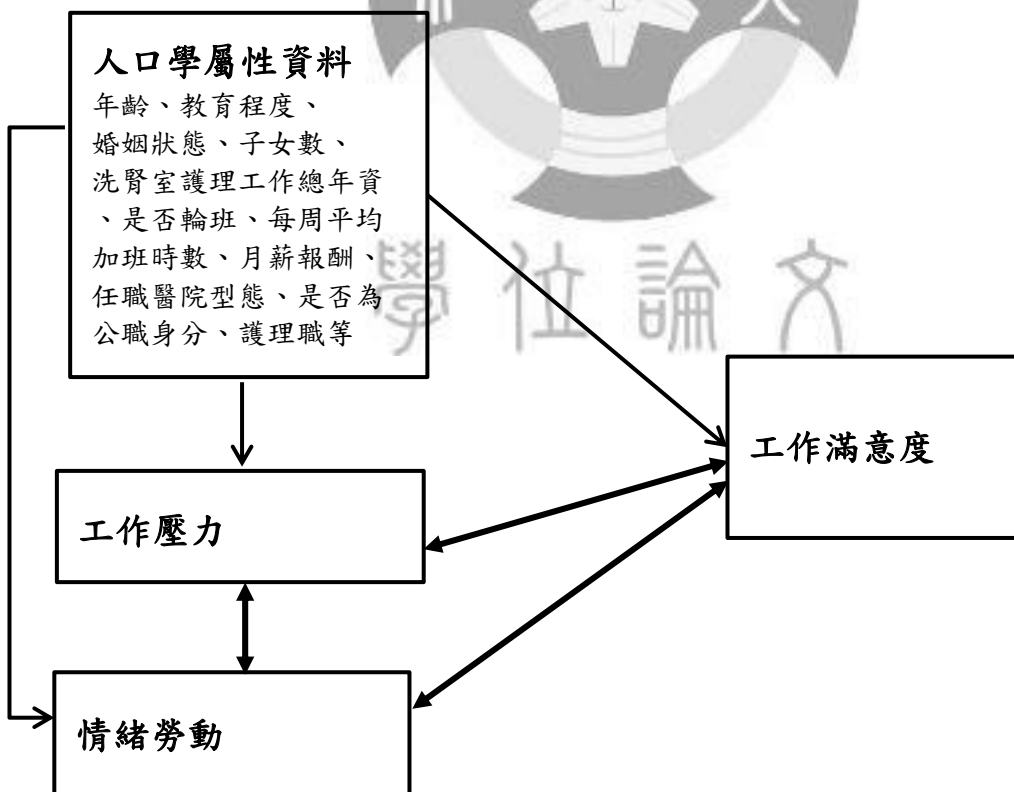


圖 1 研究架構

第二節 研究假設

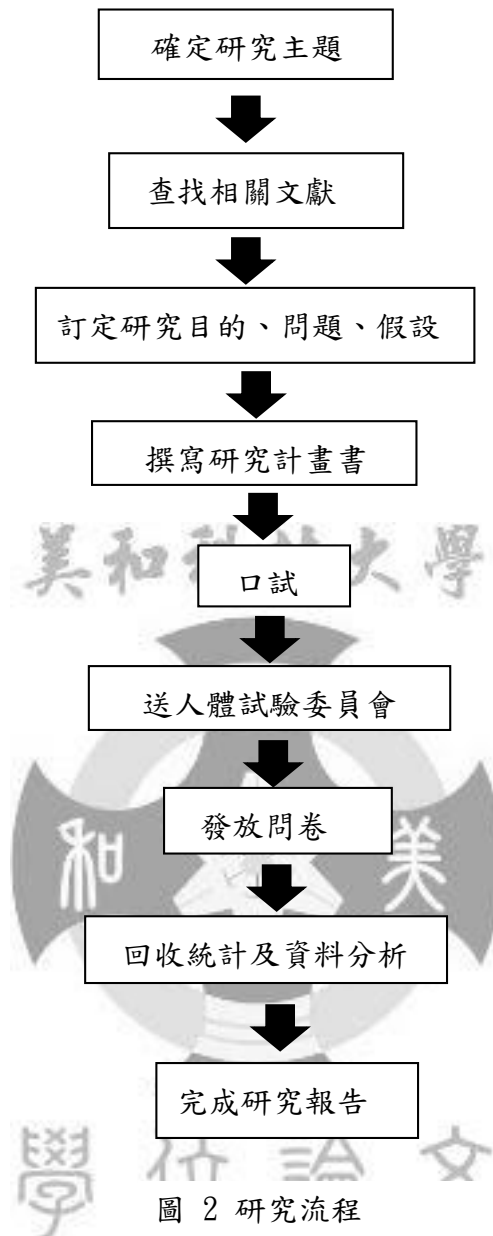
- 1.不同的人口學變項對屏東市血液透析室護理師的工作壓力、情緒勞動及工作滿意度上有顯著差異。
- 2.屏東市血液透析室護理師的工作壓力與情緒勞動有顯著正相關。
- 3.屏東市血液透析室護理師的情緒勞動與工作滿意度有顯著負相關。
- 4.屏東市血液透析室護理師的工作壓力與工作滿意度有顯著負相關。
- 5.屏東市血液透析室護理師人口學變項、工作壓力與情緒勞動是工作滿意度的重要預測因子。



第三節 研究流程

首先，確定研究題目，進行相關的文獻查找與分析，訂定研究目的、研究問題及假設，撰寫研究計畫書，預先電話連絡受試單位取得口頭同意，通過校內口試後，向人體試驗委員會提出申請，通過審查後，經美和科技大學護理系發函，向屏東市各醫院及診所之血液透析室正式提出問卷發放及回收，再將所得資料數據進行統整及分析，完成研究結果與討論撰寫。研究流程，如下圖 2。





第四節 研究設計

本研究以橫斷式研究(Cross-sectional study design)方式進行，利用方便取樣，研究對象為屏東市的醫院及診所之血液透析室的臨床護理師，本研究收案時間為 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 3 月 31 日，以結構式問卷調查，以 G-POWER 軟體估算樣本數，設定 Effect size(效果量)設 0.15、 α 值(顯著水準)設 0.05、power(檢定力)設 0.8、Number of predictors 設 11，計算出樣本數需 123 人，預估流失率 10%，故預計收案數為 135 人，收案樣本問卷內容包含血液透析護理師的基本人口學資料、工作壓力量表、情緒勞動量表及工作滿意度量表，其研究問卷採不記名方式進行。

第五節 研究工具

一、基本人口學資料屬性

本研究以自擬結構式問卷收集人口學資料，共有 11 項，內容包含受訪者年齡、教育程度、婚姻狀態、子女數、洗腎室護理工作總年資、是否輪班、每周平均加班時數、月薪報酬、任職醫院型態、是否為公職身分、護理職等，量表詳見附錄三。

二、工作壓力量表

本研究採用蔡欣玲與陳梅麗於(1996)年發表之台灣護理人員工作壓力量表，此量表最原以 Benoliel 等人(1990)所設計之量表為基礎，經原作者同意後進行翻譯，於 2019 年移交至 Multinational Association for the Promotion and Improvement of Patient-centered Outcomes Research Trust(簡稱 MAPI Research Trust)。於 2024 年 9 月 15 日，該信託機構確認授權得使用。此量表共有 47 題，分為第一部分：護理工作經驗(12 題)及護理工作情形(35 題)，在蔡與陳(1996)的研究中，可分為四個構面：個人反應(第 14.15.19.20.21.23-29.31.35-37 題)、工作關注(第 1-13.16 題)、勝任(第 17.18.22.30.32-34.42.43.45.46 題)及無法完成私人工作(第 38-41.44.47 題)，評分方式以九分法計算，分數 0 到 8 分，0 分代表最低，8 分代表最高，分數越高表示壓力越大，用來測量護理人員一周內的壓力感受，其中「勝任」構面為反向題，

各因素 Cronbach's α 均在 0.84 以上，而整體量表 Cronbach's α 為 0.93，具良好的內在一致性，量表詳見附錄三。

三、情緒勞動量表

本研究使用林尚平(2000)年發表之情緒勞動量表，該量表參考 Hochschild(1983)、Adelmann (1989)及 Morris 與 Feldman(1996)之理論概念，經五十名具工作經驗的在職學生及專家試做及修訂內容，最終版訂定為 24 題，為了將題目更適用於臨床護理人員，故經作者同意將原量表題目中的顧客改為病人，公司改為醫院，論述語意皆不變，利用以李克特量表(Likert Scale)七等級計分，1-7 分，分數越高表示情緒勞動耗費心力越大，量表分為五個構面：基本的情緒表達(第 1-5,9,10 題)、表層的情緒控制(第 6-8 題)、互動程度(11-13 題)、情緒多樣性程度(14-17 題)及深層的情緒偽裝(18-24 題)，其 Cronbach' s α 分別為 0.91、0.85、0.79、0.87、0.92，整體 Cronbach's α 為 0.97，量表詳見附錄三。

四、工作滿意度量表

本研究使用曾雯琦等人於(2017)年發表之醫院護理師工作滿意度量表，此量表經過三階段的修訂，將初版 43 題刪減為最終版 31 題，利用以李克特量表(Likert Scale)五等級計分，1 分代表「非常不滿意」、2 分「不滿意」、3 分「普通」、4 分「滿意」、5 分「非常滿意」，題目分為五個構

面:支持性的執業環境(第 1-10 題)、專業自主與發展(11-18 題)、人際互動與合作(第 19-24 題)、主管的領導風格(第 25-28 題)及護理工作的負荷(第 29-31 題), 其 Cronbach' s α 分別為 0.933、0.932、0.88、0.951、0.857, 整體 Cronbach's α 為 0.96, 可知具有良好的信效度, 量表詳見附錄三。



第六節 研究場所及對象

本研究以方便取樣方式對屏東市六家醫院血液透析中心及六家洗腎診所之血液透析護理人員進行收案，收案條件如下：

1. 具有血液透析護理師執照。
2. 任職該機構工作滿 3 個月以上且實際參與血液透析臨床工作之護理師。
3. 經解釋與說明研究目的後，同意參與本研究並寫問卷參與研究者。

排除條件：

1. 無直接照顧臨床病人之護理師。
2. 未滿 3 個月之新進護理人員。



第七節 資料處理與分析

本研究以 SPSS 26 版進行資料編碼及統計分析。統計方法包含描述性統計與推論性統計，描述性統計方法包含次數、百分比、平均數、標準差，主要用以分析研究對象人口學基本資料、工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之現況。推論性統計包含獨立樣本 T 檢定(Independent Sample t test)、單因子變異數分析(Analysis of Variance, ANOVA)、皮爾森相關分析(Pearson Correlation)，用來分析血液透析護理師人口學資料、工作壓力、情緒勞動及工作滿意度的相關性，以及多元線性迴歸分析(Multiple regression analysis)分析影響血液透析護理師工作滿意度之預測因子。

第八節 研究倫理

本研究經國軍高雄總醫院人體試驗委員會審查通過，編號：

KAFGHIRB 113-060，進行學術研究過程中，遵守道德原則和倫理標準，

以確保研究的正當性、公正性以及參與者的權益和安全。發放問卷時，研

究者清楚說明研究目的及過程，確保所有受試者知情同意且自願參加，且

過程中有權隨時退出。問卷收回時將會以編碼方式，保護參與者的個人隱

私，並確保收集的數據僅用做研究使用，以及在研究結束後如實、客觀的

呈現研究結果，並將受試者資料匿名銷毀，研究者將盡力確保研究過程不

會對受試者造成風險或傷害。



第四章 研究結果

本章共有六節，依據研究問題分成第一節血液透析護理師之現況分析；第二節血液透析護理師基本人口學與工作壓力之差異分析；第三節血液透析護理師基本人口學與情緒勞動之差異分析；第四節血液透析護理師基本人口學與工作滿意度之差異分析；第五節血液透析護理師工作壓力、情緒勞動、工作滿意度之相關性分析；第六節血液透析護理師工作滿意度之預測因子分析，茲分述如下：

第一節 血液透析護理師之現況分析

本節以 SPSS 軟體進行描述性統計，針對回收之有效問卷作現況描述，結果詳如下述。

一、 血液透析護理師基本資料之現況

收案地點為屏東市三間公立醫院、三間私立醫院和六間診所，問卷共發放 128 份，扣除 4 份問卷填寫不完整，回收之有效問卷共計 124 份。其中平均年齡為 43 歲($SD=7.74$)，最小 24 歲，最大 70 歲，41-50 歲最多(佔 61.3%)。教育程度以大學以上最多 86 人(佔 69.4%)，其次專科 38 人(佔 30.6%)。婚姻狀態以已婚最多共 85 人(佔 68.5%)，其次未婚 28 人(佔 22.6%)，離婚 11 人(佔 8.9%)。子女人數平均 1 位小孩，以 2 位小孩最多共 51 人(佔 41.1%)，無生小孩 37 人(佔 29.8%)，1 位小孩 24 人(佔 19.4%)，3

位小孩以上 12 人(佔 9.7%)。洗腎室護理工作總年資平均 13.81 年 (SD=8.47)，最少 1 年，最多 32 年，以 0-5 年最多 30 人(佔 24.2%)，其次 16-20 年 28 人(佔 22.6%)，最少為 26 年以上有 11 人(佔 8.9%)。輪班方面，需要輪班有 87 人(佔 70.2%)，不需要輪班 37 人(佔 29.8%)。每周平均加班時數平均為 4.28 小時(SD=3.41)，最少加班 0 小時，最多加班 16 小時，以加班 5 小時以上最多為 59 人(佔 47.6%)，其次不須加班的人數為 27 人(佔 21.8%)，最少者為加班 1-2 小時為 14 人(佔 11.3%)。月薪報酬以 4.1-4.5 最多 46 人(佔 37.1%)，其次 3.6-4 萬有 28 人(佔 22.6%)，最少為 3-3.5 萬及 5.6 萬以上各有 9 人(佔 7.3%)。任職醫院形態方面，在醫院工作有 55 人(佔 44.4%)，在診所工作有 69 人(佔 55.6%)。公職身份方面，公職身份有 10 人(佔 8.1%)，非公職身份有 114 人(佔 91.9%)。護理職等以 N2 最多 50 人(佔 40.3%)，其次 N0 有 37 人(佔 29.8%)，最少為 N3 以上有 12 人(佔 9.7%)。

綜合上述，本研究對象年齡平均 43 歲，教育程度多為大學以上為主，已婚者居多；平均子女數為 1 人；洗腎室護理工作總年資平均 13.81 年；以輪班為主；每周平均加班時數平均為 4.28 小時，加班 5 小時以上人數最多，月薪報酬以 4.1-4.5 萬最多，大多數受試者在診所工作，非公職身分居多，護理能力進階以 N2 者為多數（表 1）。

表 1 人口基本學資料分析

(N=124)

研究變項	人數	百分比%	平均值±標準差	最小值	最大值
年齡			43.68(±7.74)	24	70
21-30 歲	9	7.3			
31-40 歲	25	20.2			
41-50 歲	76	61.3			
51 歲以上	14	11.3			
教育程度					
專科	38	30.6			
大學(二技、四技)	86	69.4			
以上					
婚姻狀態					
已婚	85	68.5			
未婚	28	22.6			
離婚	11	8.9			
子女數			1(±1.02)	0	4
0 人	37	29.8			
1 人	24	19.4			
2 人	51	41.1			
3 人以上	12	9.7			
洗腎室護理工作總年資			13.81(±8.47)	1	32
0-5 年	30	24.2			
6-10 年	20	16.1			
11-15 年	20	16.1			
16-20 年	28	22.6			
21-25 年	15	12.1			
26 年以上	11	8.9			
是否輪班					
是	87	70.2			
否	37	29.8			

表 1 人口基本學資料分析(續)

(N=124)

每周平均加班時數		4.28(± 3.41)	0	16
0 小時	27	21.8		
1-2 小時	14	11.3		
3-4 小時	24	19.4		
5 小時以上	59	47.6		
月薪報酬				
3-3.5 萬	9	7.3		
3.6-4 萬	28	22.6		
4.1-4.5 萬	46	37.1		
4.6-5 萬	21	16.9		
5.1-5.5 萬	11	8.9		
5.6 萬以上	9	7.3		
任職醫院型態				
醫院	55	44.4		
診所	69	55.6		
是否為公職身分				
是	10	8.1		
否	114	91.9		
護理職等				
N0	37	29.8		
N1	25	20.2		
N2	50	40.3		
N3 以上	12	9.7		

二、 血液透析護理師工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之現況

本研究參考蔡欣玲與陳梅麗發表之台灣護理人員工作壓力量表共有 47 題，分數 0 到 8 分，0 分代表最低，8 分代表最高，分數越高表示壓力越大，以此量表四個構面的整體平均值做排序，其中勝任構面為反向題，已將得分做反向編碼再計算平均值，分數最高排序第一位在「個人反應」為 4.59(SD=2.29)，第二位在「無法完成私人工作」為 4.45(SD=2.16)，第三位在「勝任」為 4.14(SD=2.05)，第四位在「工作關注」為 4.01(SD=2.62)，整體工作壓力量表平均分數 4.30(SD=2.10)，結果顯示血液透析室護理師工作壓力在「個人反應」的感受程度明顯。

在情緒勞動之現況分析中，使用林尚平教授發表之情緒勞動量表共有 24 題，計分方式 1-7 分，分數越高表示情緒勞動耗費心力越大，此量表分為五個構面，以整體平均值做排序，分數最高排序第一位在「深層的情緒偽裝」為 4.43(SD=1.88)，第二位在「基本的情緒表達」為 4.38(SD=1.95)，第三位在「表層的情緒控制」為 4.33(SD=2.08)，第四位在「互動程度」為 4.23(SD=2.00)，第五位在「情緒多樣性程度」為 4.02(SD=2.11)，整體情緒勞動量表平均分數 4.28(SD=1.90)，結果顯示血液透析室護理師情緒勞動在「深層的情緒偽裝」所耗費的心力較大。

在工作滿意度之現況分析中，使用曾雯琦等人發表之護理師工作滿意

度量表共有 31 題，計分方式 1-5 分，分數越高表示滿意度越高，此量表分為五個構面，以整體平均值做排序，分數最高排序第一位在「人際互動與合作」為 3.23(SD=0.91)，第二位在「主管的領導風格」為 3.17(SD=1.08)，第三位在「專業自主與發展」為 3.06(SD=0.92)，第四位在「支持性的執業環境」為 2.86(SD=0.93)，第五位在「護理工作的負荷」為 2.73(SD=1.01)，整體工作滿意度量表平均分數 3.01(SD=0.88)，結果顯示血液透析室護理師工作滿意度在「人際互動與合作」方面有較高的滿意程度。

綜合上述，血液透析室護理師工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之現況為工作壓力方面在「個人反應」的感受程度最明顯，情緒勞動在「深層的情緒偽裝」所耗費的心力最大，工作滿意度在「人際互動與合作」方面有較高的滿意程度（表 2）。

表 2 工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之現況分析

(N=124)

項目	範圍	最小值	最大值	構面平均數	標準差	排序
工作壓力構面	0-376					
個人反應(16 題)		0	126	4.59	2.29	1
工作關注(14 題)		0	110	4.01	2.62	4
勝任(11 題)		2	88	4.14	2.05	3
無法完成私人工作(6 題)		0	46	4.45	2.16	2
工作壓力總量表				4.30	2.10	
情緒勞動構面	24-168					
基本的情緒表達(7 題)		7	49	4.38	1.95	2
表層的情緒控制(3 題)		3	21	4.33	2.08	3
互動程度(3 題)		3	21	4.23	2.00	4
情緒多樣性程度(4 題)		4	28	4.02	2.11	5
深層的情緒偽裝(7 題)		7	49	4.43	1.88	1
情緒勞動總量表				4.28	1.90	
工作滿意度構面	31-155					
支持性的執業環境(10 題)		11	50	2.86	0.93	4
專業自主與發展(8 題)		11	40	3.06	0.92	3
人際互動與合作(6 題)		7	30	3.23	0.91	1
主管的領導風格(4 題)		4	20	3.17	1.08	2
護理工作的負荷(3 題)		3	15	2.73	1.01	5
工作滿意度總量表				3.01	0.88	

第二節 血液透析護理師基本人口學與工作壓力之差異分析

本節探討不同人口學變項的血液透析室護理師在工作壓力量表上的差異，採用獨立樣本 T 檢定及單因子變異數分析，若變異數分析中組間因子達.05 顯著水準，則進一步使用雪費法（Scheffe）進行組別間的事後檢定，統計分析結果如下。

年齡方面，21-30 歲的工作壓力量表平均數為 4.74、31-40 歲平均數 4.03、41-50 歲平均數 4.37、51 歲以上平均數 4.12，($F=.32$ ； $p=.809$)，結果未達顯著差異。教育程度方面，專科平均數 4.15、大學(二技、四技)以上平均數 4.36，($t=-.50$ ； $p=.618$)，結果未達顯著差異。婚姻狀態方面，已婚平均數 4.18、未婚平均數 4.17、離婚平均數 5.51，($F=2.03$ ； $p=.135$)，結果未達顯著差異。子女數方面，0 人平均數 3.99、1 人平均數 4.95、2 人平均數 4.22、3 人以上平均數 4.25，($F=1.05$ ； $p=.372$)，結果未達顯著差異。洗腎室護理工作總年資方面，0-5 年平均數 4.38、6-10 年平均數 4.06、11-15 年平均數 4.40、16-20 年平均數 4.01、21-25 年平均數 4.66、26 年以上平均數 4.54，($F=.28$ ； $p=.921$)，結果未達顯著差異。輪班方面，要輪班平均數 4.31、不用輪班平均數 4.27，($t=.10$ ； $p=.919$)，結果未達顯著差異。每周平均加班時數方面，0 小時平均數 2.92、1-2 小時平均數 3.01、3-4 小時平均數 4.19、5 小時以上平均數 5.28，($F=12.63$ ； $p<.001$)，

結果表示顯著，事後檢定發現每周平均加班 5 小時以上 > 0 小時、1-2 小且達顯著差異。月薪報酬方面，3-3.5 萬平均數 4.36、3.6-4 萬平均數 4.63、4.1-4.5 萬平均數 4.53、4.6-5 萬平均數 3.45、5.1-5.5 萬平均數 3.60、5.6 萬以上平均數 4.82，($F=1.30$ ； $p=.268$)，結果未達顯著差異。任職醫院型態方面，醫院平均數 3.04、診所平均數 5.30，($t=-7.47$ ； $p<.001$)，表示診所 > 醫院結果顯著。是否為公職身分方面，公職平均數 3.41、非公職平均數 4.37，($t=-2.29$ ； $p=.036$)，表示非公職工作壓力顯著大於公職。護理職等方面，N0 平均數 4.71、N1 平均數 4.99、N2 平均數 3.95、N3 以上平均數 3.00，($F=3.53$ ； $p=.017$)，但事後比較未達顯著差異(表 3)。

綜合上述可知，在工作壓力總量表中，不受年齡、教育程度、婚姻狀態、子女數、洗腎室護理工作總年資、是否輪班、月薪報酬不同而有差異。每周平均加班 5 小時以上之得分高於 0 小時、1-2 小時、診所工作者得分高於醫院工作者、非公職身份得分高於公職身份具顯著差異。

表 3 人口變項在工作壓力總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析 (n=124)

變項	樣本數	平均值	標準差	F 值/t 值	p 值	Scheffe 法
年齡				.32	.809	
21-30 歲	9	4.74	2.14			
31-40 歲	25	4.03	1.77			
41-50 歲	76	4.37	2.21			
51 歲以上	14	4.12	2.17			
教育程度				.50	.618	
專科	38	4.15	2.07			
大學(二技、四技)以上	86	4.36	2.12			
婚姻狀態				2.03	.135	
已婚	85	4.18	2.11			
未婚	28	4.17	1.92			
離婚	11	5.51	2.24			
子女數				1.05	.372	
0 人	37	3.99	1.79			
1 人	24	4.95	2.26			
2 人	51	4.22	2.15			
3 人以上	12	4.25	2.42			

表 3 人口變項在工作壓力總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析(續) (n=124)

洗腎室護理工作				.28	.921
總年資					
0-5 年	30	4.38	1.78		
6-10 年	20	4.06	1.90		
11-15 年	20	4.40	2.18		
16-20 年	28	4.01	2.42		
21-25 年	15	4.66	2.20		
26 年以上	11	4.54	2.43		
是否輪班				.10	.919
是	87	4.31	2.09		
否	37	4.27	2.15		
每周平均加班時數				12.63	<.001***
0 小時(1)	27	2.92	1.16		(4)>(1)、
1-2 小時(2)	14	3.01	2.09		(2)
3-4 小時(3)	24	4.19	2.21		
5 小時以上(4)	59	5.28	1.89		
月薪報酬				1.30	.268
3-3.5 萬	9	4.36	2.46		
3.6-4 萬	28	4.63	2.14		
4.1-4.5 萬	46	4.53	2.14		
4.6-5 萬	21	3.45	1.78		
5.1-5.5 萬	11	3.60	1.78		
5.6 萬以上	9	4.82	2.25		

表 3 人口變項在工作壓力總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析(續) (n=124)

任職醫院型態				-7.47	<.001***
醫院	55	3.04	1.16		
診所	69	5.30	2.15		
是否為公職身分				-2.29	.036*
是	10	3.41	1.16		
否	114	4.37	2.15		
護理職等				3.53	.017*
N0	37	4.71	2.24		事後比較
N1	25	4.99	2.18		未達顯著
N2	50	3.95	1.89		
N3 以上	12	3.00	1.63		

* $P < .05$, ** $P < .01$, *** $P < .001$

第三節 血液透析護理師基本人口學與情緒勞動之差異分析

本節探討不同人口學變項的血液透析室護理師在情緒勞動量表上的差異，採用獨立樣本 T 檢定及單因子變異數分析，若變異數分析中組間因子達.05 顯著水準，則進一步使用雪費法（Scheffe）進行組別間的事後檢定，統計分析結果如下。

年齡方面，21-30 歲的勞動情緒量表平均數為 5.36、31-40 歲平均數 3.88、41-50 歲平均數 4.35、51 歲以上平均數 3.89，($F=1.57$ ； $p=.199$)，結果未達顯著差異。教育程度方面，專科平均數 4.08、大學(二技、四技)以上平均數 4.36，($t=-.71$ ； $p=.476$)，結果未達顯著差異。婚姻狀態方面，已婚平均數 4.14、未婚平均數 4.23、離婚平均數 5.39，($F=2.12$ ； $p=.124$)，結果未達顯著差異。子女數方面，0 人平均數 4.14、1 人平均數 4.50、2 人平均數 4.20、3 人以上平均數 4.41，($F=.18$ ； $p=.910$)，結果未達顯著差異。洗腎室護理工作總年資方面，0-5 年平均數 4.50、6-10 年平均數 4.05、11-15 年平均數 4.45、16-20 年平均數 3.97、21-25 年平均數 4.50、26 年以上平均數 4.24，($F=.34$ ； $p=.884$)，結果未達顯著差異。輪班方面，要輪班平均數 4.25、不用輪班平均數 4.34，($t=-.22$ ； $p=.821$)，結果未達顯著差異。每周平均加班時數方面，0 小時平均數 3.13、1-2 小時平均數 3.38、3-4 小時平均數 3.90、5 小時以上平均數 5.18，($F=11.39$ ； $p<.001$)，

結果表示顯著，事後檢定發現每周平均加班 5 小時以上>0 小時、1-2 小及 3-4 小時且達顯著差異。月薪報酬方面，3-3.5 萬平均數 4.16、3.6-4 萬平均數 4.54、4.1-4.5 萬平均數 4.44、4.6-5 萬平均數 3.77、5.1-5.5 萬平均數 3.65、5.6 萬以上平均數 4.69，($F=7.79$ ； $p=.555$)，結果未達顯著差異。任職醫院型態方面，護理師任職醫院之情緒勞動平均數為 3.39、診所平均數 4.98，($t=-5.23$ ； $p<.001$)，表示診所血液透析護理師之情緒勞動較任職於醫院之血液透析護理師高且達顯著差異。是否為公職身分方面，公職平均數 3.93、非公職平均數 4.31，($t=-1.04$ ； $p=.312$)，結果未達顯著差異。護理職等方面，N0 平均數 4.48、N1 平均數 4.67、N2 平均數 4.12、N3 以上平均數 3.47，($F=1.33$ ； $p=.268$)，結果未達顯著差異(表 4)。

綜合上述可知，在情緒勞動總量表中，不受年齡、教育程度、婚姻狀態、子女數、洗腎室護理工作總年資、是否輪班、月薪報酬、是否為公職身分及護理職等不同而有差異。每周平均加班 5 小時以上之得分高於 0 小時、1-2 小時及 3-4 小時、診所工作者得分高於醫院工作者具顯著差異。

表 4 人口變項在情緒勞動總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析

(n=124)

變項	樣本數	平均值	標準差	F 值/t 值	P 值	Scheffe 法
年齡				1.57	.199	
21-30 歲	9	5.36	1.65			
31-40 歲	25	3.88	1.77			
41-50 歲	76	4.35	1.94			
51 歲以上	14	3.89	1.94			
教育程度				-1.71	.476	
專科	38	4.08	2.08			
大學(二技、四技)以上	86	4.36	1.82			
婚姻狀態				2.12	.124	
已婚	85	4.15	1.92			
未婚	28	4.23	1.75			
離婚	11	5.39	1.92			
子女數				.18	.910	
0 人	37	4.19	1.67			
1 人	24	4.50	2.26			
2 人	51	4.20	1.92			
3 人以上	12	4.41	1.93			

表 4 人口變項在情緒勞動總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析(續) (n=124)

洗腎室護理工作				.34	.884
總年資					
0-5 年	30	4.50	1.80		
6-10 年	20	4.05	1.68		
11-15 年	20	4.45	1.69		
16-20 年	28	3.97	2.12		
21-25 年	15	4.50	2.14		
26 年以上	11	4.24	2.26		
是否輪班				-.22	.821
是	87	4.25	1.89		
否	37	4.34	1.95		
每周平均加班時數				11.39	<.001***
0 小時(1)	27	3.12	1.22		(4)>(1)、
1-2 小時(2)	14	3.38	1.94		(2)、(3)
3-4 小時(3)	24	3.90	2.12		
5 小時以上(4)	59	5.18	1.63		
月薪報酬				.79	.555
3-3.5 萬	9	4.16	2.23		
3.6-4 萬	28	4.54	1.91		
4.1-4.5 萬	46	4.44	1.98		
4.6-5 萬	21	3.77	1.61		
5.1-5.5 萬	11	3.65	1.71		
5.6 萬以上	9	4.69	2.06		

表 4 人口變項在情緒勞動總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析(續) (n=124)

任職醫院型態				-5.23	<.001***
醫院	55	3.39	1.40		
診所	69	4.98	1.96		
是否為公職身分				-1.04	.312
是	10	3.93	0.97		
否	114	4.31	1.96		
護理職等				1.33	.268
N0	37	4.48	2.00		
N1	25	4.67	2.13		
N2	50	4.12	1.75		
N3 以上	12	3.47	1.56		

* $P < .05$, ** $P < .01$, *** $P < .001$

第四節 血液透析護理師基本人口學與工作滿意度之差異分析

本節探討不同人口學變項的血液透析室護理師在工作滿意度量表上的差異，採用獨立樣本 T 檢定及單因子變異數分析，若變異數分析中組間因子達.05 顯著水準，則進一步使用雪費法（Scheffe）進行組別間的事後檢定，統計分析結果如下。

年齡方面，21-30 歲之工作滿意度平均數得分為 2.70、31-40 歲平均數 3.14、41-50 歲平均數 2.99、51 歲以上平均數 3.09，($F=.58$ ； $p=.627$)，結果未達顯著差異。教育程度方面，專科平均數 3.04、大學(二技、四技)以上平均數 3.00，($t=.22$ ； $p=.826$)，結果未達顯著差異。婚姻狀態方面，已婚平均數 3.01、未婚平均數 3.19、離婚平均數 2.56，($F=2.03$ ； $p=.136$)，結果未達顯著差異。子女數方面，0 人平均數 3.15、1 人平均數 2.63、2 人平均數 3.08、3 人以上平均數 3.04，($F=1.97$ ； $p=.121$)，結果未達顯著差異。洗腎室護理工作總年資方面，0-5 年平均數 3.00、6-10 年平均數 3.14、11-15 年平均數 2.77、16-20 年平均數 3.20、21-25 年平均數 2.89、26 年以上平均數 2.92，($F=.71$ ； $p=.615$)，結果未達顯著差異。輪班方面，要輪班平均數 3.05、不用輪班平均數 2.91，($t=.78$ ； $p=.435$)，結果未達顯著差異。每周平均加班時數方面，0 小時平均數 3.66、1-2 小時平均數 3.35、3-4 小時平均數 3.13、5 小時以上平均數 2.58，($F=13.30$ ； $p<.001$)，

結果表示顯著，事後檢定發現每周平均加班 0 小時、1-2 小時及 3-4 小時 >5 小時以上達顯著差異。月薪報酬方面，3-3.5 萬平均數 2.85、3.6-4 萬平均數 2.96、4.1-4.5 萬平均數 2.92、4.6-5 萬平均數 3.26、5.1-5.5 萬平均數 3.26、5.6 萬以上平均數 2.89，($F=.71$ ； $p=.617$)，結果未達顯著差異。任職醫院型態方面，醫院平均數 3.43、診所平均數 2.68，($t=5.32$ ； $p<.001$)，表示醫院>診所結果顯著。是否為公職身分方面，公職平均數 3.38、非公職平均數 2.98，($t=2.09$ ； $p=.055$)，結果未達顯著差異。護理職等方面，N0 平均數 2.91、N1 平均數 2.78、N2 平均數 3.12、N3 以上平均數 3.37，($F=1.68$ ； $p=.175$)，結果未達顯著差異(表 5)。

綜合上述可知，在工作滿意度總量表中，不受年齡、教育程度、婚姻狀態、子女數、洗腎室護理工作總年資、是否輪班、月薪報酬、是否為公職身份及護理職等不同而有差異。每周平均加班 0 小時、1-2 小時及 3-4 小時之得分高於加班 5 小時以上、醫院工作者得分高於診所工作者具顯著差異。

表 5 人口變項在工作滿意度總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析 (n=124)

變項	樣本數	平均值	標準差	F 值/t 值	P 值	Scheffe 法
年齡				.58	.627	
21-30 歲	9	2.70	0.83			
31-40 歲	25	3.14	0.82			
41-50 歲	76	2.99	0.93			
51 歲以上	14	3.09	0.76			
教育程度				.22	.826	
專科	38	3.04	0.93			
大學(二技、四技)以上	86	3.00	0.87			
婚姻狀態				2.03	.136	
已婚	85	3.01	0.86			
未婚	28	3.19	0.78			
離婚	11	2.56	1.19			
子女數				1.97	.121	
0 人	37	3.15	0.77			
1 人	24	2.63	0.83			
2 人	51	3.08	0.93			
3 人以上	12	3.04	0.98			

表 5 人口變項在工作滿意度總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析(續) (n=124)

洗腎室護理工作				.71	.615
總年資					
0-5 年	30	3.00	0.80		
6-10 年	20	3.14	0.80		
11-15 年	20	2.77	0.90		
16-20 年	28	3.20	0.95		
21-25 年	15	2.89	1.00		
26 年以上	11	2.92	0.89		
是否輪班				0.78	.435
是	87	3.05	0.88		
否	37	2.91	0.89		
每周平均加班時數				13.30	<.001***
0 小時(1)	27	3.66	0.61		(1)、(2)、
1-2 小時(2)	14	3.35	0.83		(3)>(4)
3-4 小時(3)	24	3.13	0.79		
5 小時以上(4)	59	2.58	0.81		
月薪報酬				.71	.617
3-3.5 萬	9	2.85	0.78		
3.6-4 萬	28	2.96	0.80		
4.1-4.5 萬	46	2.92	0.95		
4.6-5 萬	21	3.26	0.97		
5.1-5.5 萬	11	3.26	0.77		
5.6 萬以上	9	2.89	0.77		

表 5 人口變項在工作滿意度總量表平均之單因子變異數及 t 檢定分析(續) (n=124)

任職醫院型態				5.32	<.001***
醫院	55	3.43	0.62		
診所	69	2.68	0.92		
是否為公職身分				2.09	.055
是	10	3.38	0.53		
否	114	2.98	0.90		
護理職等				1.68	.175
N0	37	2.91	0.85		
N1	25	2.78	1.01		
N2	50	3.12	0.83		
N3 以上	12	3.37	0.85		

* $P < .05$, ** $P < .01$, *** $P < .001$

第五節 血液透析護理師工作壓力、情緒勞動、工作滿意度之相關性分析

本節透過皮爾森相關分析，探討血液透析室護理師的工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之間的相關性，統計結果如下：

工作壓力與情緒勞動之間呈現高度正相關 ($r=.909$ ， $p<.01$)，顯示工作壓力越高，護理師在情緒勞動各方面的負荷也越大；工作壓力與工作滿意度之間呈現高度負相關 ($r=-.846$ ， $p<.01$)，說明個人工作壓力較大時，護理師在執業中感受的滿意度較低；而情緒勞動與工作滿意度之間也呈現高度負相關($r=-.835$ ， $p<.01$)，表示越高的情緒勞動感受會導致工作滿意度越低(表 6)。

表 6 血液透析室護理人員工作壓力、情緒勞動與工作滿意度相關分析 (n=124)

	工作壓力	情緒勞動	工作滿意度
工作壓力	1		
情緒勞動	.909**	1	
工作滿意度	-.846**	-.835**	1

** $P < .01$



綜合上述可知，工作壓力與情緒勞動呈高度正相關，而這兩者皆與工作滿意度呈高度負相關，顯示壓力與情緒負荷較重的護理師，對於工作的滿意程度較低並顯示這些變項在護理工作環境中具有重要的相互關聯性。

第六節 血液透析護理師工作滿意度之預測因子分析

本節探討血液透析室護理師工作滿意度的重要預測因子，以人口學變項、工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之分析結果可發現每周平均加班時數、任職醫院型態、工作壓力及情緒勞動具有相關性，故將上述變項以多元線性迴歸分析法放入的自變項，工作滿意度當作依變項並將其中的每周平均加班時數轉為虛擬變數，以用於迴歸分析模式中。從表中分析結果可發現「工作壓力」、「情緒勞動」、「每周平均加班時數 5 小時以上」為工作滿意度之重要預測因子， R^2 為 0.754，調整後的 R^2 為 0.742，解釋變異量達總變異量的 74.2%，效果達到顯著差異(表 7)。

表 7 血液透析室護理師工作滿意度之複迴歸分析

變項	R	R ²	調整後 R ²	模式 F 值	未標準化係數 B	標準化迴 歸係數 β	T	P 值	共線性統計量 VIF	
(常數)	.868	.754	.742	59.848***	4.694	.148	31.809	.000***		
每周平均加班時數 (1-2hr VS 0hr)					-.291	.158	-.104	-1.840	.137	1.531
每周平均加班時數 (3-4hr VS 0hr)					-.181	.138	-.081	-1.313	.186	1.809
每周平均加班時數 (5hr 以上 VS 0hr)					-.281	.119	-.159	-2.352	.009**	2.178
醫院型態					.085	.107	.048	.795	.859	1.741
工作壓力					-.220	.052	-.522	-4.182	.000***	7.414
情緒勞動					-.155	.053	-.335	-2.926	.003**	6.224

* $P < .05$, ** $P < .01$, *** $P < .001$

第五章 討論

本章共有六節，依據研究結果分成第一節血液透析護理師現況之討論；第二節血液透析護理師基本人口學與工作壓力之差異討論；第三節血液透析護理師基本人口學與情緒勞動之差異討論；第四節血液透析護理師基本人口學與工作滿意度之差異討論；第五節血液透析護理師工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之相關性討論；第六節探討血液透析護理師工作滿意度之預測因子討論，茲分述如下：

第一節 血液透析護理師現況之討論

本研究對象年齡平均 43 歲，以 41-50 歲的護理師最多，與張念慈 (2023)、黃守智 (2018) 的研究相似，顯示血液透析室工作以資深人員為主，較少年輕人投入或留任；教育程度多為大學為主，已婚者居多，與邱瑞鈴 (2019) 的研究相似，顯示透析護理師的專業要求高，相較於其他科別，透析室的工作穩定單純，故較易吸引有家庭照顧的護理人員投入；洗腎室護理工作總年資平均 13.81 年；以輪班為主，與吳淑華 (2018)、Hayes 等 (2015) 的研究相似，顯示在職者多具備豐富的臨床經驗，輪班制度也反映出此領域長期需應對不間斷病患照護的特性；而護理能力進階以 N2 者為多數與張念慈 (2022) 的研究相似，反映出多數護理師具備一定專業能力，但未達最高職等，或許與進修

機會或職涯晉升受限有關。

在工作壓力方面，本研究的工作壓力量表總平均為 4.30 分，屬於中上程度，與 Hayes 等人(2015)、吳淑華(2017)及詹佩蓉(2020)研究探討血液透析護理人員的結果相同，其中又以詹佩蓉研究次量表中的「個人反應」構面之壓力程度最高，與本研究相同，個人反應構面內容主要是以護理師在經歷工作壓力時所產生的負面感受(蔡欣玲、陳美麗，1996)，例如焦慮、沮喪或易怒，並伴隨對身心健康的影響，如食慾減退或暴飲暴食、失眠以及頻繁的頭痛或肌肉緊繃等身體反應，顯示出血液透析護理師的心理支持與身體健康問題需要特別關注。血液透析護理師的工作主要為提供腎衰竭病人進行血液透析，包括對病人的整體健康評估、透析過程的監控、併發症的處理及衛教與心理支持等多方面，工作環境要求高，對護理師來說，體力和腦力負荷都很大，隨著全球對透析治療的需求穩定成長，也導致血液透析護理師的心理及工作壓力程度上升(Westergren & Lindberg, 2023)。另外根據 Wu 等人(2018)的研究中針對華人蒐集了 11337 名護理人員的資料顯示工作壓力程度也屬於中等程度。

在情緒勞動方面，本研究的情緒勞動量表總平均為 4.28 分與多數研究均指出護理人員的整體情緒勞動偏高相同(高潔純 & 吳珮甄，

2015；詹佩蓉，2020；Hong & Lee, 2016；Wu et al., 2018），與何玉菁（2022）研究結果不同，相異的是在何玉菁的研究中護理人員「互動程度」與「基本情緒表達」構面是主要造成情緒勞動的因素，而本研究為「深層的情緒偽裝」構面所耗費的心力最大，推測原因可能為血液透析護理師面對慢性腎臟病患者長期的透析治療，因病情不可逆，容易使病患產生焦慮、沮喪甚至憤怒等情緒；而護理師在臨床工作時，往往需要展現關懷與溫暖的態度，這種觀念成為他們專業養成的一部分，特別是在血液透析領域(黃秋鵬等，2010；詹佩蓉，2020)，而深層的情緒偽裝代表著較高度的情緒失調，迫使護理師壓抑或改變內心真實的感受，需要投入更多的心理努力，以符合工作需求，展現大愛與同理心來對待病患，以維持專業形象與患者良好的互動(陳柵君等，2021)有關，但這種表裡不一的情緒管理常會在下班後造成心理損害(Yang et al., 2025)。

在工作滿意度方面，本研究的工作滿意度量表總平均為 3.01 分與其他研究指出護理人員的整體工作滿意度中等相同(Hayes et al.,2015；Wu et al., 2018)，然在 Hayes 等(2015)及 Labragu 等(2019)的研究中，專業自主發展是導致工作滿意度最高的因素；而黃守智(2018)的研究中指出，血液透析護理師對主管領導風格感受最為滿意，在主管的帶領下，使得單位運作更加順利，同事間相處關係融洽，亦提升工作滿

意度；在陳秋曲等(2024)的研究中以「對於與護理同儕的互動情形」感到滿意度最高，此與本研究結果呈現「人際互動與合作」構面滿意程度最高類似，推測血液透析護理師在臨床上需依賴團隊合作，彼此協助共同應對突發狀況，無論是與同儕、醫療團隊或是跨部門的協調，良好的互動與溝通是很重要的，而當護理人員感受到與醫療團隊的合作氣氛良好時，其工作滿意度也會顯著提升(Yang et al., 2025)。



第二節 血液透析護理師基本人口學與工作壓力之差異討論

根據第四章研究結果，可知血液透析室護理師在工作壓力總量表中，不受年齡、教育程度、婚姻狀態、子女數、洗腎室護理工作總年資、是否輪班、月薪報酬不同而有差異。在蔡沂好(2024)針對加護病房護理人員照護確診病患工作壓力之探討及陳美惠(2023)針對加護病房護理人員工作壓力與休閒參與身心健康之探討的研究中，撫養的子女數對工作壓力具有顯著影響；在 Tuna et al (2023)的研究結果中，發現醫護人員之婚姻狀態對工作壓力呈現相關性，其未婚者工作壓力較低；然何玉菁等(2022)的研究結果呈現出工作壓力不會因為年資長短而有所差異；而另有研究指出年輕、未婚、無子女、輪班或固定上夜班的護理人員，其工作壓力偏高(高潔純、吳珮甄，2015；林采怡、林弘昌，2019；Okuhara et al., 2021)，根據人口學現況分析推測原因為血液透析護理師多為已婚、有子女且長期從事血液透析工作，對於工作壓力與家庭責任間已取得平衡，故較無顯著影響。本研究每周平均加班時數與工作壓力具有顯著相關，其加班 5 小時以上之壓力得分高於 0 小時及 1-2 小時與王藝蓁(2023)及周千惠(2022)的研究結果相同，現今許多醫療機構因為護理人員不足，導致現有護理師需要分擔額外工作，加班已成為常態，長期加班可能影響身心狀況及生活作息，加劇工作壓力的感受。另外本研究發現診所工作者壓力高於醫院工作

者，與普遍認知醫院工作者之壓力高於診所工作者任珊珊 (2020)不同，推測原因可能為診所通常採取高密度的治療排程，患者數量多，透析治療時間緊湊，導致護理人員需連續操作，休息時間較少且診所的醫護人員配置通常較精簡，相較於醫院可能缺乏支援性人員（如勤務或護佐等），護理人員需獨立完成多項工作，另外，診所的薪資結構可能與醫院不同，使得護理人員工作量大但未能領到相對應的報酬。本研究也發現非公職身份之工作壓力高於公職身份，與林延柔 (2019)研究中某公立醫院 205 位護理人員不同，但與吳佳珉 (2024)探討急診護理人員相同，推測非公職護理人員壓力較高可能原因為工作保障不穩定及薪資福利較差。

第三節 血液透析護理師基本人口學與情緒勞動之差異討論

根據第四章研究結果，可知血液透析室護理師在情緒勞動總量表中，不受年齡、教育程度、婚姻狀態、子女數、洗腎室護理工作總年資、是否輪班、月薪報酬及是否為公職身份不同而有差異，此與羅天佑 (2024)、李敏瑤(2023)研究結果相同。在張文馨 (2024)研究中發現中部某醫院 200 名護理人員之年齡、婚姻狀態、子女數在情緒勞動上有顯著差異，根據血液透析護理師工作的特殊性，推測原因為情緒勞動主要來自長時間反覆面對末期腎臟病病患的照顧及要求，而非個人生活背景，故對年齡、婚姻狀態、撫養的子女數等較無顯著影響。護理年資與情緒勞動成正相關(何玉菁，2022；楊超欽等，2016)；本研究都為女性護理人員，在性別方面女生比男生有更高的情緒勞動 (Zhou et al., 2025)；而本研究每周平均加班 5 小時以上之情緒勞動得分高於 0 小時、1-2 小時及 3-4 小時與邱文信(2019)蒐集 205 位護理人員的研究結果相似，推測可能原因為加班時間越長意味著更多時間面對病患及其家屬，需持續展現同理心、關懷與耐心，進而造成更大的情緒耗損。本研究發現診所工作者情緒勞動程度大於醫院工作者，推測可能原因為血液透析診所人力編制通常比醫院少，故護理人員常需同時負責技術操作、病患的心理支持、非護理專業工作等雜事，情緒負擔自然加重且診所多為私人開設，重視病患滿意度與回診率，因此

對護理人員的態度及情緒表現可能要求更高，但在陳怡伶(2016)361

名護理人員中之研究結果則發現無顯著差異。



第四節 血液透析護理師基本人口學與工作滿意度之差異討論

根據第四章研究結果，可知血液透析室護理師在工作滿意度總量表得分中，不受年齡、教育程度、婚姻狀態、子女數、洗腎室護理工作總年資、是否輪班、月薪報酬、是否為公職身份及護理職等不同而有差異，此與黃守智(2018)探討血液透析護理師之研究結果相似。而與其他研究結果不同，可發現年齡與工作滿意度具有正向相關性(Hayes et al., 2015；Wu et al., 2018；Yeo & Ha, 2025)；教育程度與工作滿意度具有相關性(Tuna et al., 2023)；婚姻狀態與工作滿意度具有相關性，但在 Tuna 等人(2023)的研究中未婚者滿意度高於已婚者，而 Yeo & Ha (2025)的研究中已婚者滿意度高於未婚者。工作年資方面，年資與工作滿意度具有相關性(Hayes et al., 2015；Wu et al., 2018；Yeo & Ha, 2025)，其中工作超過 20 年的滿意度更高。在(楊佩瑄等，2024)針對台灣南部一所醫院 189 名護理師的統計結果發現學士以上學歷、月收入 7 萬以上、有子女的受訪者工作滿意度相對較高；在職等方面，護理專業能力進階越高者，工作滿意度越高(張美玉、張碧華，2023)。而本研究每周平均加班 0 小時、1-2 小時及 3-4 小時之工作滿意度得分高於加班 5 小時以上與(吳美珠等，2018)蒐集 144 位專科護理師及(陳美錦，2012)蒐集 150 位麻醉護理師的研究結果相似，可得出加班時數越高，工作滿意度越低。而本研究醫院工作者的滿意程度

高於診所工作者與陳怡伶(2016)的研究相同，根據構面分析推測原因可能為執業環境較優、職涯發展與專業進修機會多、團隊合作氛圍較佳、主管領導風格較好及工作內容分工較細，負擔相對低。



第五節 血液透析護理師工作壓力、情緒勞動及工作滿意度之相關性 討論

根據第四章統計結果可得知，工作壓力與情緒勞動方面呈現正相關，此與鄭任程 (2017)探討 184 位護理人員之研究結果相同，詹佩蓉 (2020)針對 250 名血液透析護理師的研究中可知，情緒勞動對工作壓力具有顯著正向影響，當血液透析護理人員情緒勞動程度越高時，其工作壓力感受也越大；Kim (2020)則提出護理人員情緒勞動中的表層情緒控制越大對工作壓力的感受越強烈，並建議院方須努力提供介入措施，提高護理人員在與病人互動時管理情緒的能力，可能會有效減輕護理人員的工作壓力。在何玉菁等(2022)的研究中發現情緒勞務會影響護理人員的工作壓力，醫院應重視護理人員情緒管理議題，可辦理相關課程訓練其自我情緒調適能力或舒壓活動，以降低壓力感受。

本研究結果發現血液透析護理人員之工作壓力與工作滿意度呈現負相關，與 Shader 等人(2001)對醫院各部門護理人員的研究、吳美珠 (2018)對專科護理師的研究及 Yeo & Ha (2025)對血液中心護理師的研究結論相似，推測工作壓力感受到達一定程度會削弱了護理人員對職場環境與工作內容的正面評價。Lu 等人(2019)在針對醫院護理師工作滿意度的文獻回顧中指出工作壓力與工作滿意度呈負向關係，此研究

整合 59 篇文獻，結果顯示工作壓力高常源自於人力短缺、工作量大、輪班制度、角色衝突與人際關係緊張等因素並強調降低工作壓力對提升護理師滿意度與穩定護理人力具有關鍵意義。特別針對現今護理人員執業率低的狀況，醫院對於新進人員工作壓力也更加重視，多數新進護理人員普遍感受到的壓力，主要來自責任重大、非專業性工作的負擔過重，以及護理工作項目繁多，這些因素常導致延遲下班的情況。此外，許多新人也會因自覺專業知識與技能不足，在面對臨床上各種突發狀況時感到無力與焦慮，另外，也提到新人即使對臨床老師的教導抱持高度認同，也無法因此而減輕在面對繁重工作與照顧過多病患時所產生的壓力。由此可見，這些壓力並非單靠人際支持可以緩解，仍需從制度面改善根本問題，故應更致力於協助新人建立紮實的護理專業知識與技能，才能培養出應對臨床工作上的壓力與困難(劉彩娥、王萬琳，2023)。值得一提的是 Hayes 等人(2014)針對 417 名血液透析護理師的研究提到了工作壓力和工作滿意度的反向關係，研究者提及血液透析護理師能替病患治療及提供心理支持時的成就感可提高工作滿意度，但同時工作壓力也增加，因為工作過程中常伴隨著情緒耗竭，由於血液透析中特殊的醫病關係，使得工作人員與病患頻繁且長期的接觸，使得關係過於親密且界線模糊，甚至比家人的關係更緊密，而隨著病程進展其病患們陸續走到生命的盡頭，護理人員時

常陷入反覆悲傷的循環中而導致工作壓力上升與無法緩解的失落及哀傷。

本研究在情緒勞動與工作滿意度方面呈現負相關，與 Yin and Wang (2018)對急診護理師的研究、Altaş 等人(2023)、Xu & Fan(2023)對醫院護理師的研究結果相似。在台灣，不同學者之研究有不同見解，根據陳雅玲(2024)對台南地區大型醫院執業之護理師調查發現護理人員的情緒勞務與工作滿意度呈現顯著負向影響，建議管理者與院方須重視護理人員的情緒健康，提供適切的資源，以提升滿意度。相反的，在王靖儒(2020)的研究則提出不同的看法，顯示情緒勞務對工作滿意度呈正相關，推測其原因可能為「視病猶親」的態度有助於護理師從中獲得成就感，進而提高工作滿意度，透過調整內在情緒來展現真誠的關懷，反而有助於建立工作價值感，正向影響工作滿意度。推測不同的研究結果可能為血液透析護理師工作的特殊性，在工作中時常面對固定病患的需求，累積的心理負擔影響工作的滿意感。

第六節 探討血液透析護理師工作滿意度之預測因子討論

根據第四章預測因子分析可得知，「工作壓力」、「情緒勞動」、「每周平均加班時數 5 小時以上」為工作滿意度之重要預測因子，解釋變異量達總變異量的 74.2%，與吳美珠(2018)對 144 位專科護理師的研究結果類似，工作壓力為工作滿意度的重要預測因子。在 Hwang & Park(2022)對 424 臨床護理師其研究結果顯示工作壓力與情緒勞動中可解釋工作滿意度總變異量的 45.0%，也代表這兩個變項對護理人員的工作滿意度具有高度解釋力，亦反映出臨床護理師在面對高度情緒勞務與壓力情境時，其主觀滿意感受受到顯著影響。工作滿意度是一個多面向、主觀性且動態變化的心理狀態，基於自身期望與實際經驗之間的符合程度，受到職業環境、專業發展、人際互動、主管風格、工作負荷等有關。在加班時數方面，張彩秀、張淑萍等(2013)研究中提到超時工作會影響病人安全，甚至增加病人死亡風險，而研究結果發現護理人員工作時數與工作滿意度雖然有正相關，但未達顯著相關，推測原因為護理人員寧願將自己份內的事情超時加班做完，也不願留給下一班接手，增加別人的工作負擔，故造成即使工時增加，滿意度未必呈現明顯較差，而深入檢視工作內容可發現以書寫護理記錄最為費時，建議簡化重複性護理單張，言簡意賅做重點描述紀錄；以及走路、核對醫囑、補耗材最為費時，建議改善護理站動線規劃及

增加人員備物熟悉度，院所若能正視並提升員工的工作滿意度，將有助於建立穩定、高效與具正向文化的職場環境。除此之外，在張怡萱等(2024)的研究中也表示認真負責與外向人格特質的護理人員，其工作滿意度明顯較高，因為負責任的人傾向自律、重視細節、具備責任感，並以完成工作目標為導向，當好的工作表現獲得正面評價及肯定，會提升整體的工作滿意度，而外向人格樂於與人互動、情緒正向，容易在團體中建立良好的人際關係，護理行業是為一種高度依賴團隊合作與溝通的工作，也可呼應本研究結果中「人際互動與合作」構面是工作滿意度最高的構面。



第六章 結論與建議

本章共有三節，分成第一節結論，第二節建議及第三節研究限制，茲分述如下：

第一節 結論

根據第三章研究假設可得知不同的人口學變項對屏東市血液透析室護理師的工作壓力、情緒勞動及工作滿意度上有顯著差異，其研究結果為每周平均加班時數及任職醫院型態對工作壓力、情緒勞動及工作滿意度上有顯著相關，而是否為公職身分對工作壓力有顯著相關。再者，屏東市血液透析室護理師的工作壓力對情緒勞動有顯著正相關；工作壓力與情緒勞動對工作滿意度有顯著負相關以及每周平均加班時數 5 小時以上、工作壓力、情緒勞動為工作滿意度之重要預測因子，解釋變異量達總變異量的 74.2%。

第二節 研究限制

1.本研究對象僅針對屏東市的血液透析室護理師，可能無法完全代表其他地區或全國血液透析護理師的情況，影響結果的外部效度。

2.本研究採用橫斷式設計，只能探討變項之間的相關性，無法確定因果關係，例如高工作壓力是否導致低工作滿意度，還是低工作滿意度加重了工作壓力，難以明確界定並且可能還有其他構面和變項須納入作探討，才能做到精準預測。

3.屏東地區無醫學中心，無法推及醫學中心的護理師感受，且本次收案之診所，無明確劃分診所之定義，故部分受試者工作院所為聯合診所，運作模式及規模類似小型醫院，可能進而導致研究結果有所誤差。

4.本次收案無男性護理人員，故在性別方面的差異，結果推論亦會有所限制。

5.本研究工具為紙本問卷，欲了解工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之關係現況，但由於臨床工作繁忙且研究對象必須輪班的原因，未能即時請護理師填寫完畢並回收問卷，故採取親自到各醫療院所發放問卷再擇日取回，雖以和受試院所之窗口說明問卷填答規則，問卷中也清楚說明填答方式，並且提供聯絡電話可詢問填寫時所遇到的問

題，但仍難以避免研究對象對問卷題目的不了解或是礙於工作當下情緒亦或是因問卷題數過多而導致填答時出現偏差的情況，資料填寫的正確性無法嚴格把關，而影響結果推論。

6.在搜尋國內外血液透析透護理師與此三項變項之文章發現，相關文獻偏少，難以進行直接比較。



第三節 建議

綜合研究結果，針對臨床實務、行政管理及教學層面提出以下建議：

1.臨床實務

應重視加班管理與人力安排，由於每週加班時數超過 5 小時會顯著影響護理人員的工作壓力與滿意度，建議透析院所應合理配置人力，避免長期依賴加班制度，增加第一線護理人員負荷；建立情緒支持機制，考量情緒勞動與工作壓力有密切相關，建議設置定期心理支持活動、舒壓課程或同儕支持團體，供臨床護理人員參加，幫助提升情緒調節與應對策略。

2.行政管理

建議行政領導層改善工作環境，增加人力資源及非公職人員的工作保障，應提供更多資源與獎勵制度提升工作滿意度、減少壓力來源，並且可定期進行員工滿意度調查以即時了解基層人員的想法做政策上的調整。

3.研究教學層面

可以考慮擴大研究範圍、增加樣本數、採用混合研究方法，如訪

談與問卷結合或進行縱向研究，以更全面了解血液透析護理師的工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之關係。此外，增加質性訪談才能確切知道護理人員的需求，以臨床第一線的護理師想法為主，實際提出解決方式。



參考文獻

- 于芍盈(2021)·護理人員的情緒勞務研究：專業知覺、心理資本、與中庸思維的探討〔碩士論文，中原大學〕·華藝線上圖書館。
- 于劍興(2023)·一針入魂 團隊相伴. 人醫心傳—慈濟醫療人文月刊(231), 24-29.
- 中華民國護理師護士公會全國聯合會(2024)·台閩地區護理師統計，取自
<https://www.nurse.org.tw/publicUI/H/H10201.aspx?arg=8DC2E451DACBBC4071>
- 王怡琰、曾淑萍(2023)·觀護人工作壓力、工作滿意度與職業倦怠關聯性之探究·犯罪學研究(2), 1-51。
- 王靖儒(2020)·臨床護理師自我效能、情緒勞務及工作滿意度之相關性-以北部兩醫院為例 元培醫事科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統 新竹市。
- 王藝蓁(2023)·COVID-19 專責醫院護理人員之工作壓力與自覺健康狀況探討〔碩士論文，義守大學〕·華藝線上圖書館。
- 台灣腎臟醫學會(2024)·台灣腎臟醫學會「血液透析」護理人員資格核定申請辦法，取自
https://www.tsn.org.tw/news_detail.html?id=558c403e-fa36-454d-bffe-4b835d499ba0
- 全民健康保險統計(2022)·衛生福利部中央健康保險署，取自
<https://www.nhi.gov.tw/ch/np-2994-1.html>
- 任珊珊(2020)·不同工作性質護理人員的工作壓力與職業承諾對於工作意願關聯之研究 經國管理暨健康學院]. 臺灣博碩士論文知識加值系統。
- 何玉菁、王淑珍、徐傑冠、傅美瓊、邢鴻君、李幸樺(2022)·護理人員情緒勞務、情緒智力、工作壓力與留任意願之關聯性探討·醫院雜誌, 55(2), 46-60。
- 吳佳珉(2024)·台東地區急診護理人員工作壓力、壓力因應與留任意願之相關性探討 亞洲大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統·台中市。
- 吳美珠、陳亞玲、莊玉仙、邱玉萍、吳靜華、蔡麗君、李慧咪、林淑婷、黃淑儀(2018)·專科護理師工作壓力、職場疲勞與工作滿意度之相關性探討·安泰醫護雜誌, 24(1), 1-13。

- 吳淑華(2018)·血液透析護理人員的正念、工作壓力與專業生活品質之相關性探討 長庚科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統·桃園縣。
- 呂佳芬(2023)·護理人員輪調壓力與工作滿意相關探討-以北部某區域醫院為例 長庚大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統·桃園縣。
- 宋佩佳(2018)·性別與工作滿意度之探討·全球科技管理與教育期刊, 7(1), 52-57。
- 余鳳霞(2014)·淺談血液透析工作中護患溝通的技巧·中國醫藥指南, (2014 年 02), 217-218。
- 岑俐玟(2024)·工作壓力、工作滿意度及職業倦怠之相關研究-以幼兒園教保服務人員為例 華梵大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統·新北市。
- 李月麗、施登瓊、江彥菽、沈桂鳳、潘慧娟、李育珮、陳麗系 (2021)·護理人員靈性健康與工作滿意度之相關探討·高雄護理雜誌, 38(1), 1-13。
- 李正涼(2022)·屏東地區專科護理師專業能力與工作壓力之研究 美和科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統·屏東縣。
- 李昭婷 (2021)·彰化縣國中小學校護理人員工作壓力與工作滿意度關係之研究 國立暨南國際大學].
- 李敏瑤(2023)·探討 COVID-19 衝擊下護理人員情緒勞務與職業倦怠對離職傾向之影響 美和科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統·屏東縣。
- 李選(1992)·某綜合醫院新進護理人員專業規劃與諮商對改善工作壓力與離職率成效之探討·護理雜誌, 39(2), 115-125。
- 周千惠(2022)·新冠肺炎疫情衝擊下公共衛生護理人員工作壓力與職場疲勞之探討-以台南市為例 中華醫事科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統·台南市。
- 林清戀、李萍、劉朧、劉虎沉、王多璚 (2013)·醫院血液透析工作流程的 Pro-Model 建模分析·現代醫藥衛生, (2013 年 10), 1582-1585。
- 林正士(2014)·情緒勞務工作者與人力資源管理措施：整合分析觀點·國立金門大學學報(4), 39-64。
- 林効賢(2020)·以工作滿意度與忠誠度來談飯店人力永續管理的關鍵因素·休閒保健期刊(24), 1-30。

- 林尚平(2000)．組織情緒勞務負擔量表之發展．*中山管理評論*, 8(3), 427-447。
- 林延柔(2019)．工作壓力、工作滿意度及主觀幸福感之相關性研究 - 以中部某公立醫院護理人員為例 [中臺科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台中市。
- 林采怡、林弘昌(2019)．探討臨床護理人員的工作壓力、自我效能對工作滿意度之影響．*科技與人力教育季刊*, 5(4), 92-116。
- 邱文信(2019)．護理人員情緒勞務與工作倦怠之研究 [美和科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．屏東縣。
- 邱瑞鈴(2019)．探討血液透析護理人員透析照護教育訓練需求評估 [國立臺北護理健康大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台北市。
- 韋氏大詞典(1996)．英語辭典．取自 <https://www.merriam-webster.com/>
- 柯惠文、阮祺文、張秀如(2011)．護理人員與病患照護服務員下背痛之相關因素探討．*秀傳醫學雜誌*, 10(1&2), 69-80。
- 胡曉玲、張寶琪、林佳慧、陳淑貞(2021)．臨床護理人員之情緒勞務經驗．*中華職業醫學雜誌*, 28(3), 269-279。
- 高月慈、謝幸燕、鄭惠珠 (2024)．顧客不文明行為與護理人員工作滿意度及助人組織公民行為關聯之探討：情感專業承諾的中介效應．*澄清醫護管理雜誌*, 20(1), 7-15。
- 高潔純、吳珮甄 (2015)．加護單位護理人員之情緒勞務探討．*醫院雙月刊*, 48(4), 34-45。
- 陸國強(2000)．朗文當代高級辭典 (第四版)．培生教育出版中國有限公司。
- 張怡萱、黃崢茶、羅英瑛、葉淑娟(2024)．護理人員人格特質與工作滿意度之相關性—以職場霸凌氛圍為調節變項．*醫學與健康期刊*, 13(2), 19-32。
- 張彩秀、張淑萍、陳妮婉(2013)．護理人員工作時數與工作滿意度之關係探討．*弘光學報*, (69), 12-25。
- 張文馨 (2024)．護理人員工作特性、情緒勞務、組織承諾與離職傾向之相關研究-以中部某醫院為例 [國立雲林科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．雲林縣。

- 張念慈 (2023)．血液透析護理人員血管通路理學檢查之教育訓練需求評估 國立臺北護理健康大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台北市。
- 張美玉、張碧華(2023)．護理人員職涯發展、職涯發展方案、工作滿意度與留任意願之探討．榮總護理, 40(3), 270-280。
- 張偉斌、何政勳、溫信財、林玉珊(2020)．公共衛生護理人員工作壓力、主管支持與工作滿意之相關性．北市醫學雜誌, 17(4), 412-424。
- 張淑銘(2020)．苗栗縣血液透析室護理人員職業疲勞與工作生活品質之研究 中華大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．新竹市。
- 許惠菁(2020)．數位時代護理人員之工作滿意度與離職傾向相關因素之探討-以南部區域教學醫院為例 吳鳳科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．嘉義縣。
- 許閔惠(2022)．醫事護理人員之工作壓力、養生休閒與身心狀態之研究-以新竹某醫院為例 育達科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．苗栗縣。
- 許靖岱、陳湘揚、陳惠娟、莊昭華(2013)．護理人員輪班現況調查．彰化護理, 20(4), 8-13。
- 許劍橋(2022)．製作「南丁格爾」：臺灣護理書寫的自我呈現與世代衍異．漢學研究集刊(35), 173-211。
- 陳冬蜜(2021)．南部某醫學中心急診室護理人員職場疲勞、工作滿意度與離職傾向之相關性探討 美和科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．屏東縣。
- 陳玄康、何高志(2023)．以校長分佈式領導提升工作滿意度之策略．學校行政(144), 83-103。
- 陳怡伶(2016)．內外控人格特質、情緒勞動與工作滿意度 對組織承諾：以網路世代護理人員為例 南臺科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台南市。
- 陳柔安(2020)．情緒勞動、工作壓力、工作績效與高績效工作系統之關聯研究-以台灣企業為例 大同大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台北市。
- 陳柵君、陳冠仰、許中華(2021)．從情感事件理論探討負面事件對護理師情緒勞務、離職傾向及服務行為之影響．健康科技期刊,

8(1), 1-15。

陳秋曲、李姿月、趙麗玫、吳姿蓉(2024)．後疫情時代護理人員的工作壓力、工作滿意度與韌性之相關性與預測因子．*護理雜誌*, 71(4), 44-56。

陳美惠(2023)．加護病房護理人員工作壓力與休閒參與身心健康之探討-彰化某區域教學醫院為例 明道大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．彰化縣。

陳美錦 (2012)．南部醫學中心麻醉護理人員工作壓力、工作滿意度與生活品質相關性探討 美和科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．屏東縣。

陳淑貞、張寶琪、歐乃嘉、尹玗、廖珍娟(2021)．護理人員壓力復原力、工作滿意度及留任意願之相關性探討．*中華職業醫學雜誌*, 28(3), 245-258。

陳淑純、陳美華、張倩蜜、康美玉、謝孟蓁、張翠芬、粘沛琳、錢美容、李雅文(2022)．探討護理人員照顧 COVID-19 病人的工作壓力與復原力．*榮總護理*, 39(4), 400-411。

陳雅玲 (2024)．護理人員情緒勞務、工作倦怠、工作滿意 對離職傾向關係之研究-以台南地區大型醫院為例 崑山科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台南市。

黃秋鵬、李密、李姮瑛(2010)．血液透析護士素質要求探討．*中外健康文摘*，223-224。

黃守智(2018)．血液透析護理人員對組織氣氛、護理工作滿意度 與留任意願之研究 東南科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．新北市。

曾玉華、高玉貞、林懿如 (2021)．降低血液透析過程人工腎臟凝固發生率之護理專案．*臺灣腎臟護理學會雜誌*, 19(2), 35-48。

曾俊維、顏芳姿(2024)．新冠支援者的調動與不被看見的護理勞動．*人文社會與醫療學刊*(11), 1-28。

曾雯琦、林秋芬、林麗英、盧美秀、蔣立琦(2017)．發展臺灣醫院護理師工作滿意度量表與信效度檢測．*護理雜誌*, 64(2), 44-54。

黃素枝、吳婷婷、周嘉宜 (2021)．南部某醫學中心護理人員之安全態度調查分析．*榮總護理*, 38(1), 37-46。

- 黃彩珍 (2023)．公衛護理人員的情緒勞務、公共服務動機與職業倦怠關聯性之研究 國立臺南大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台南市。
- 黃聖芳(2024)．護理人員工作壓力、社會支持與工作滿意度之相關研究-以中部某區域醫院為例 中臺科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台中市。
- 楊文杰(2024)．職場工作壓力、工作倦怠、角色壓力、情緒勞動與離職傾向之影響 南華大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．嘉義縣。
- 楊佩瑄、曾櫻花、鄭素珍 (2024)．曾確診 COVID-19 護理師留任意願重要預測因子之探討．護理雜誌, 71(2), 58-69。
- 楊舒雅 (2024)．論血液透析護理人員的身心照護．彰化護理, 31(2), 16-21。
- 楊超欽、朱正一、陳春明、邱議瑩 (2016)．精神科護理人員工作壓力與情緒智力對自覺健康生活品質之影響．醫務管理期刊, 17(2), 79-96。
- 詹佩蓉、雷燕萍、黃千郁.(2020)．探討血液透析護理人員情緒勞動、工作壓力與生活品質關係之研究—以中部地區為例．澄清醫護管理雜誌, 16(3), 29-36。
- 詹雯月(2021)．探討護理人員情緒勞動、工作壓力與生活品質關係之研究 吳鳳科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．嘉義縣。
- 趙子揚、陸偉明 (2019)．過量教育、學用不一對於工作滿意度的影響．教育研究與發展期刊, 15(3), 93-127。
- 劉佩均(2020)．護理人員情緒勞動對工作滿意度之影響及其中介歷程探討：工作要求-資源模式觀點 中臺科技大學。
- 劉彩娥、王萬琳(2023)．探討新進護理人員護理實習經驗與職場工作壓力之關係．醫院雜誌，56(1)，41-56。
- 劉迅、范培金(2004)．基層醫院開展血液透析工作的體會．中華全科醫師雜誌，343-344。
- 劉梅玉、張新波、郭峰岩(2012)．優質護理在血液透析工作中的應用．基層醫學論壇，2393-2393。
- 潘思宇、呂嘉薰 (2024)．洗腎都是吃太多藥造成？破解洗腎 10 大迷思．好健康(69), 23-27。

- 劍橋線上辭典(1999)．英語辭典．取自 <https://dictionary.cambridge.org/>
- 賴欣憶(2023)．衛生福利部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署、國家中醫藥研究所 113 年度單位預算評估報告．取自 <https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=46463&pid=232818>
- 蔡沂好(2024)．加護病房護理人員照護確診病患工作壓力之探討－以南臺灣某教學醫院為例 中華醫事科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．台南市。
- 蔡欣玲、陳梅麗(1996)．護理人員壓力量表之信效度測試．護理研究, 4(4), 355-362。
- 蔡美曰(2023)．探討護理人員工作策略、自我效能及工作滿意度的相關性 國立彰化師範大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．彰化縣。
- 蔡豐任 (2021)．中彰投國小教師工作壓力、角色壓力與因應策略之關係研究 國立暨南國際大學。
- 蔣凱若、張寶琪、莊蕙婉、鍾凱吉、陳淑貞、潘雪幸 (2022)．國軍醫院急診護理人員工作壓力與生活品質之相關性研究．中華職業醫學雜誌, 29(3), 181-191。
- 鄭任程 (2017)．情緒勒索、工作壓力、情緒勞務與工作倦怠之關聯性研究－以護理人員為例 國立高雄應用科技大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．高雄市。
- 韓雲楷 (2022)．超音波應用於血液透析中屢管穿刺．腎臟與透析, 34(1), 54-58。
- 羅天佑.(2024)．護理師情緒勞務因應策略研究 輔仁大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統．新北市。

英文文獻

- AbuAlRub, R., Al Sabei, S. D., Al-Rawajfah, O., Labrague, L. J., & Burney, I. A. (2023). Direct and Moderating Effects of Work Environment and Structural Empowerment on Job Stress and Job Satisfaction Among Nurses in Oman. *Sultan Qaboos University medical journal*, 23(4), 485-492.
- Adelmann, P. K. (1989). Emotional labor and employee well-being. *Doctoral Dissertation, The University of Michigan*.
- Ali, H., Fatemi, Y., Ali, D., Hamasha, M., & Hamasha, S. (2022). Investigating Frontline Nurse Stress: Perceptions of Job Demands, Organizational Support, and Social Support During the Current COVID-19 Pandemic. *Front Public Health*, 10, 839600.
- Altaş, S. S., Gündüz Çekmecelioğlu, H., Konakay, G., & Günsel, M. (2023). Relationships among supervisor support, autonomy, job satisfaction and emotional labor on nurses within the Turkey context of healthcare services. *Frontiers in Psychology*, 14, 1303170.
- Amira, C. O., & Awobusuyi, J. O. (2014). Needle-stick injury among health care workers in hemodialysis units in Nigeria: a multi-center study. *The international journal of occupational and environmental medicine*, 5(1), 1-8.
- Arnetz, J., Sudan, S., Goetz, C., Counts, S., & Arnetz, B. (2019). Nurse Work Environment and Stress Biomarkers: Possible Implications for Patient Outcomes. *journal of occupational and environmental medicine*, 61(8), 676-681.
- Batalla, V. R. D., Barrameda, A. L. N., Basal, J. M. S., Bathan, A. S. J., Bautista, J. E. G., Rebueno, M., & Macindo, J. R. B. (2019). Moderating effect of occupational stress on spirituality and depression of Registered Nurses in tertiary hospital: A structural equation model. *journal of advanced nursing*, 75(4), 772-782.
- Benoliel, J. Q., McCorkle, R., Georgiadou, F., Denton, T., & Spitzer, A. (1990). Measurement of stress in clinical nursing. *Cancer Nursing*, 13(4), 221-228.
- Bragadóttir, H., Kalisch, B. J., Flygenring, B. G., & Tryggvadóttir, G. B.

- (2023). The Relationship of Nursing Teamwork and Job Satisfaction in Hospitals. *SAGE Open Nursing*, 9, 23779608231175027.
- Çivilidağ, A., Durmaz, Ş., & Uslu, B. (2024). The Effect of Coronavirus (COVID-19) on Job Satisfaction, Work Stress and Burnout of Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Iranian journal of public health*, 53(7), 1482-1495.
- Cox, T., & Mackay, C. (1985). The measurement of self-reported stress and arousal. *British journal of psychology*, 76 (Pt 2), 183-186.
- Dictionary.com. (1995). 英語辭典. <https://www.dictionary.com/>
- Glomb, T. M., & Tews, M. J. (2004). Emotional labor: A conceptualization and scale development. *Journal of Vocational Behavior*, 64(1), 1-23.
- Gou, L., Ma, S., Wang, G., Wen, X., & Zhang, Y. (2022). Relationship between workplace ostracism and turnover intention among nurses: the sequential mediating effects of emotional labor and nurse-patient relationship. *Psychol Health Medicine*, 27(7), 1596-1601.
- Hayes, B., Bonner, A., & Douglas, C. (2015). Haemodialysis work environment contributors to job satisfaction and stress: a sequential mixed methods study. *BMC Nursing*, 14, 58.
- Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. *Berkeley: University of California Press*.
- Hong, E., & Lee, Y. S. (2016). The mediating effect of emotional intelligence between emotional labour, job stress, burnout and nurses' turnover intention. *International Journal of Nursing Practice*, 22(6), 625-632.
- Hooley, J. M., Franklin, J. C., & Nock, M. K. (2014). Chronic pain and suicide: understanding the association. *Current pain and headache reports*, 18(8), 435.
- Hoppock, R. (1935). *Job satisfaction*. New York: Harper & Row Inc.
- Hreńczuk, M. (2021). Therapeutic relationship nurse-patient in hemodialysis therapy. *Nursing Forum*, 56(3), 579-586.
- Hwang, W. J., & Park, E. H. (2022). Developing a structural equation model from Grandey's emotional regulation model to measure

- nurses' emotional labor, job satisfaction, and job performance. *Applied Nursing Research*, 64, 151557.
- Ivey, M. (2015). Substance Abuse Among Nurses. *Kentucky Nurse*, 63(4), 8-10.
- Jakobsson Larsson, B., Mannberg, M., Pöder, U., Hedström, M., & Karlsson, A. C. (2024). Registered nurses' experiences on job satisfaction in nursing home settings. *Nursing Open*, 11(6), e2224.
- James, N. (1989). Emotional labour: Skill and work in the social regulation of feelings. *The Sociological Review*, 37(1), 15-42.
- Karasek Jr, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. *Administrative science quarterly*, 285-308.
- Kim, J. S. (2020). Emotional Labor Strategies, Stress, and Burnout Among Hospital Nurses: A Path Analysis. *Journaol of Nursing Scholarship*, 52(1), 105-112.
- Labrague, L. J., McEnroe-Petitte, D. M., & Tsaras, K. (2019). Predictors and outcomes of nurse professional autonomy: A cross-sectional study. *International Journal of Nursing Practice*, 25(1), e12711.
- Latack, J. C., & Havlovic, S. J. (1992). Coping with job stress: A conceptual evaluation framework for coping measures. *Journal of Organizational Behavior*, 13(5), 479-508.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. *Springer publishing company*.
- Lee, Y., & Hwang, W. J. (2024). The impact of nurse's sense of calling, organizational commitment, job stress, and nursing work environment on patient safety management activities in comprehensive nursing care service units during the covid-19 pandemic. *BMC Nursing*, 23(1), 311.
- Ling, K., Xianxiu, W., & Xiaowei, Z. (2020). Analysis of nurses' job burnout and coping strategies in hemodialysis centers. *Medicine (Baltimore)*, 99(17), e19951.
- Lu, H., Zhao, Y., & While, A. (2019a). Job satisfaction among hospital nurses: A literature review. *International Journal of Nursing Studies*,

94, 21-31. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.01.011>

Lu, H., Zhao, Y., & While, A. (2019b). Job satisfaction among hospital nurses: A literature review. *Int J Nurs Stud*, 94, 21-31.

Mayo, E. (1933). *The Human Problems of an Industrial Civilization*. <https://doi.org/10.1038/134201b0>

Morris, J. A., & Feldman, D. C. (1996). The Dimensions, Antecedents, and Consequences of Emotional Labor. *The Academy of Management Review*, 21(4), 986-1010.

Na, S. Y., & Park, H. (2019). The Effect of Nurse's Emotional Labor on Turnover Intention: Mediation Effect of Burnout and Moderated Mediation Effect of Authentic Leadership. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 49(3), 286-297.

Organization, W. H. (2024). monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. *World health statistics 2024*, 86.

Okuhara, M., Sato, K., & Kodama, Y. (2021). The nurses' occupational stress components and outcomes, findings from an integrative review. *Nursing Open*, 8(5), 2153-2174.

Pearlin, L. I., & Schooler, C. (1978). The structure of coping. *Journal of health and social behavior*, 19(1), 2-21.

Ponce, K. L. P., Tejada-Tayabas, L. M., González, Y. C., Haro, O. H., Zúñiga, M. L., & Morán, A. C. A. (2019). Nursing care for renal patients on hemodialysis: challenges, dilemmas and satisfactions. *Rev Esc Enferm USP*, 53, e03502.

Portero de la Cruz, S., Cebrino, J., Herruzo, J., & Vaquero-Abellán, M. (2020). A Multicenter Study into Burnout, Perceived Stress, Job Satisfaction, Coping Strategies, and General Health among Emergency Department Nursing Staff. *Journal of clinical medicine*, 9(4).

Quarshie, E. N., Cheataa-Plange, H. V., Annor, F., Asare-Doku, W., & Lartey, J. K. S. (2019). Prevalence of suicidal behaviour among nursing and midwifery college students in Ghana. *Nursing Open*, 6(3), 897-906.

Saadeh, R., Khairallah, K., Abozeid, H., Al Rashdan, L., Alfaqih, M., & Alkhatatbeh, O. (2020). Needle Stick and Sharp Injuries Among

Healthcare Workers: A retrospective six-year study. *Sultan Qaboos university medical journal*, 20(1), e54-e62.

- Saurav Singh, H., & Pratima, K. (2023). Acute Complication during Hemodialysis. In K. Ayman (Ed.), *Updates on Hemodialysis* (pp. Ch. 5). IntechOpen.
- Serra, N., Botti, S., Guillari, A., Simeone, S., Latina, R., Iacorossi, L., Torreggiani, M., Guberti, M., Cicolini, G., Lupo, R., Capuano, A., Pucciarelli, G., Gargiulo, G., Tomietto, M., & Rea, T. (2023). Workload, Job Satisfaction and Quality of Nursing Care in Italy: A Systematic Review of Native Language Articles. *Healthcare (Basel)*, 11(18).
- Shader, K., Broome, M. E., Broome, C. D., West, M. E., & Nash, M. (2001). Factors influencing satisfaction and anticipated turnover for nurses in an academic medical center. *The Journal of Nursing Administration*, 31(4), 210-216.
- Shahrbabaki, P. M., Lari, L. A., Abolghaseminejad, P., Dehghan, M., Gholamrezaei, E., & Zeidabadinejad, S. (2023). The relationship between the COVID-19 anxiety and self-efficacy of patients undergoing hemodialysis: a cross-sectional study. *BMC Psychology*, 11(1), 341.
- Shokrpour, N., Sheidaie, S., Amirkhani, M., Bazrafkan, L., & Modreki, A. (2021). Effect of positive thinking training on stress, anxiety, depression, and quality of life among hemodialysis patients: A randomized controlled clinical trial. *Journal of education and health Promotion*, 10, 225.
- Siqueira, V. T., & Kurcgant, P. (2012). Job Satisfaction: a quality indicator in nursing human resource management. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 46(1), 151-157.
- Smith, P. C., Kendall, L. M., & Hulin, C. L. (1969). *The measurement of satisfaction in work and retirement: A strategy for the study of attitudes*. Rand McNally.
- Sohn, B. K., Park, S. M., Park, I. J., Hwang, J. Y., Choi, J. S., Lee, J. Y., & Jung, H. Y. (2018). The Relationship between Emotional Labor and

Job Stress among Hospital Workers. *Journal of Korean medical science*, 33(39), e246.

- Teruya, K. Y., Costa, A. C. S., & Guirardello, E. B. (2019). Job satisfaction of the nursing team in intensive care units. *Revista latino-americana de enfermagem*, 27, e3182.
- Tuna, H., Türkmen, O. O., & Albayrak, S. (2023). A study on the relationship between sociodemographic characteristics and job stress and satisfaction among healthcare workers in Turkey during the COVID-19 pandemic. *Arh Hig Rada Toksikol*, 74(1), 42-47.
- Uvais, N. A., Aziz, F., & Hafeeq, B. (2020). COVID-19-related stigma and perceived stress among dialysis staff. *J Nephrol*, 33(6), 1121-1122.
- United States Renal Data System. 2023 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of kidney disease in the United States. <https://adr.usrds.org/2023>.
- Valluri, J., & Gorton, K. L. (2022). NURSE: Five Micropractices to Reduce Stress. *Journal of Radiology Nursing*, 41(4), 352-356.
- Vr, V., & Kaur Kang, H. (2022). The Worldwide Prevalence of Nonadherence to Diet and Fluid Restrictions Among Hemodialysis Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of renal nutrition*, 32(6), 658-669.
- Westergren, E., & Lindberg, M. (2023). Haemodialysis nurses' occupational health and work-related musculoskeletal hand pain after work: A cluster analysis. *Nursing Open*, 10(6), 4064-4070.
- Westergren, E., Ludvigsen, M. S., & Lindberg, M. (2020). Associations between materials used and work-related musculoskeletal hand complaints among haemodialysis nurses. *Journal of renal care*, 46(3), 185-192.
- Wharton, A. S., & Erickson, R. J. (1993). Managing emotions on the job and at home: Understanding the consequences of multiple emotional roles. *The Academy of Management Review*, 18(3), 457-486.
- Wizner, K., Gaspar, F. W., Biggio, A., & Wiesner, S. (2021). Occupational injuries in California's health care and social assistance industry,

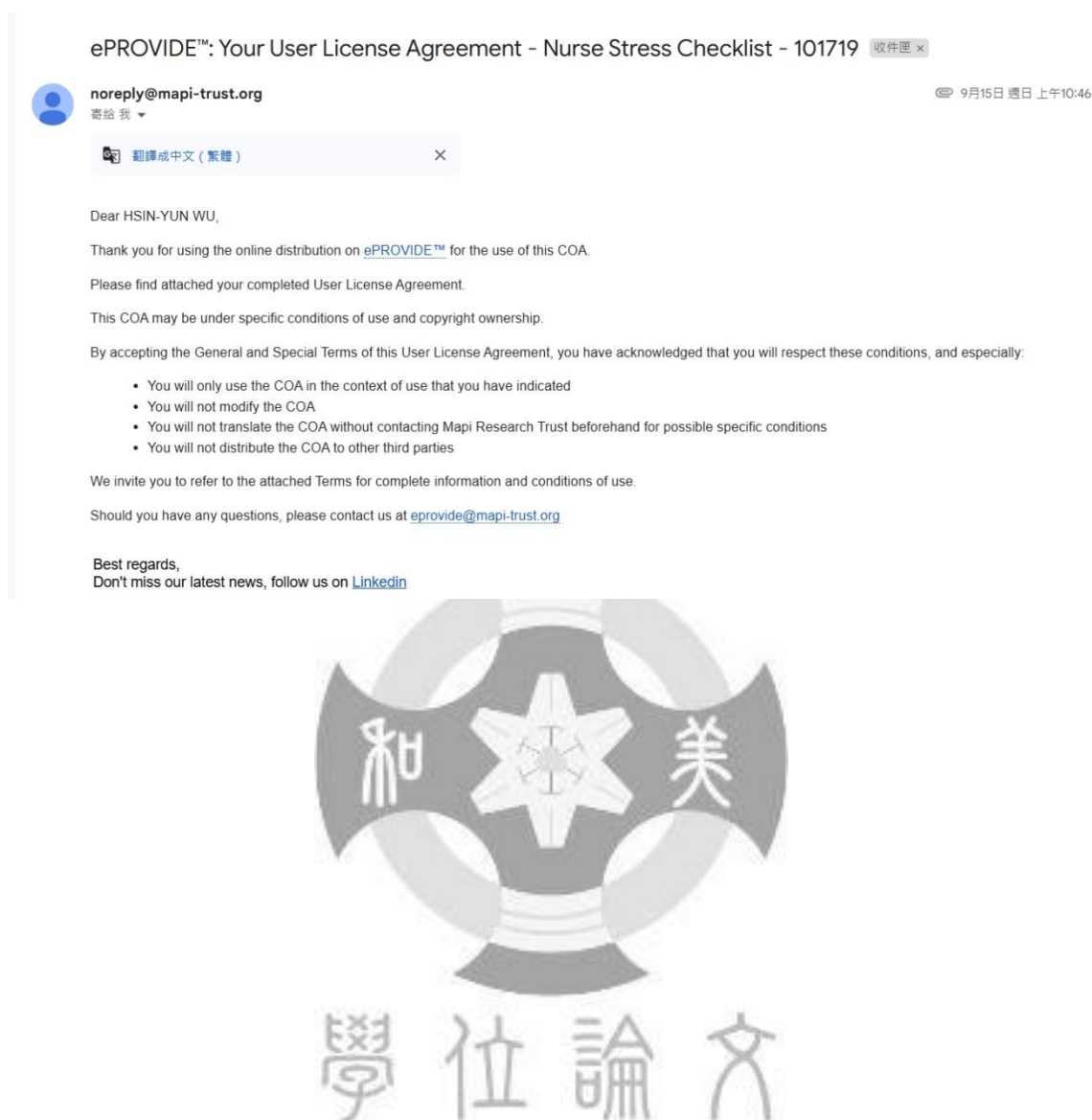
2009 to 2018. *Health science reports*, 4(2), e306.

- Wu, X., Li, J., Liu, G., Liu, Y., Cao, J., & Jia, Z. (2018). The effects of emotional labor and competency on job satisfaction in nurses of China: A nationwide cross-sectional survey. *international journal of nursing sciences*, 5(4), 383-389.
- Xu, Y. W., & Fan, L. (2023a). Emotional labor and job satisfaction among nurses: The mediating effect of nurse-patient relationship. *Front Psychology*, 14, 1094358.
- Xu, Y. W., & Fan, L. (2023b). Emotional labor and job satisfaction among nurses: The mediating effect of nurse-patient relationship. *Frontiers in Psychology*, 14, 1094358.
- Yang, H., Lv, J., Zhou, X., Liu, H., & Mi, B. (2017). Validation of work pressure and associated factors influencing hospital nurse turnover: a cross-sectional investigation in Shaanxi Province, China. *BMC health services research*, 17(1), 112.
- Yang, X., Yu, R., & Zhao, H. (2025). Survey and Analysis of Mental Health among Otolaryngology Nurses Following the Conclusion of COVID-19 Prevention and Control Measures. *British Journal Hospital Medicine (London)*, 86(3), 1-19.
- Yeo, D. W., & Ha, Y. (2025). Job Satisfaction Among Blood Center Nurses Based on the Job Crafting Model: A Mixed Methods Study. *Asian Nursing Research*, 19(1), 96-103.
- Yıldırım Keskin, A., & Şentürk, S. (2023). Being A Hemodialysis Nurse During the COVID-19 Pandemic: A Phenomenological Approach. *Omega (Westport)*, 87(2), 665-683.
- Yin, H. H., & Wang, W. J. (2018). [The correlation between job satisfaction and emotional labor surface performance of nurses in emergency department]. *Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases*, 36(10), 752-754.
- Yahoo Dictionary.(2001).英漢辭典.
https://tw.dictionary.search.yahoo.com/;_ylt=AwrtkEsFI_Rmb_MO_WYh9rolQ
- Zhou, L., Xiong, W., Hu, M., & Chang, H. (2025). Emotional labor and its

influencing factors of clinical nurses: a cross-sectional study based on latent profile analysis. *Frontiers in Public Health*, 13, 1496648.

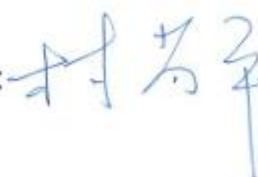


附錄一 研究問卷授權使用書



研究問卷使用授權書

本人 林尚平 茲同意美和科技大學護理系健康照護碩士班研究生 吳欣芸 使用 情緒勞務 之問卷設計，作為研究論文之研究工具。
本同意書僅限於同意該問卷作為學術研究之用，並在適當處註明出處，以符合學術論作之規定。

授權人：

中華民國 113 年 10 月 4 日

問卷出處：組織情緒勞務負擔量表之發展

附錄二 研究問卷

親愛的護理同仁，您好：

感謝您撥空參與這項研究，本研究旨在探討血液透析護理師的工作壓力、情緒勞動與工作滿意度，此問卷分四個大題，每一大題皆有明確的說明評分方式，請依照您的實際感受填答。

本問卷為匿名填寫，所有回答僅用於學術研究，且會嚴格保密，您的回應對我們深入了解這一議題至關重要，請確保每一題完成作答！

再次謝謝您對本研究的支持，敬祝您身體健康，工作順利！

美和科技大學

美和科技大學健康照護研究所

指導教授：韓彤珍 博士

研究生：吳欣芸 敬啟

E-mail: bellas031016@gmail.com

第一部分：人口基本學資料 請在適當的選項內☐

1. 年齡：出生年份_____，_____月
2. 教育程度：1.☐專科 2.☐大學(四技、二技) 3.☐碩士 4.☐博士
3. 婚姻狀態：1.☐已婚 2.☐未婚 3.☐離婚
4. 子女數：_____人
5. 洗腎室護理工作總年資：_____年
6. 是否輪班：1.☐是 2.☐否
7. 每周平均加班時數：_____小時
8. 月薪報酬：1.☐3-3.5 萬 2.☐3.6-4 萬 3.☐4.1-4.5 萬 4.☐4.6-5 萬

5. ☐ 5.1-5.5 萬 6. ☐ 5.6-6 萬 7. ☐ 6.1 萬以上

9. 任職醫院型態：1. ☐ 醫院 2. ☐ 診所

10. 是否為公職身分：1. ☐ 是 2. ☐ 否

11. 護理職等：1. ☐ N0 2. ☐ N1 3. ☐ N2 4. ☐ N3 5. ☐ N4

第二部份：工作壓力量表，請詳細閱讀題目後，依照您這一週對壓力的實際感受，○圈選相對應的數字，0 分為完全沒有，8 分為完全符合。

題目	評分程度
1.擔心個人安全	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
2.工作落後	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
3.不易讓醫師了解自己的意思	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
4.醫師不接納我的意見	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
5.病人的各項治療互相矛盾	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
6.時間不夠用。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
7.沒有足夠的時間完成該做的事。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
8.無法滿足病人的要求。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
9.無法回答病人或家屬的問題。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
10.與病人或家屬討論問題到不自在。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
11.不同意醫師對病人的治療目標。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
12.醫療體系有缺陷，難以符合病人需要。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
13.我的注意力難以集中。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
14.我覺得氣餒。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

15.常常擔心。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16.下班時仍念念不忘病人的情形。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17.我覺得很有自信	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18.我能圓滿完成能力範圍內的工作。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
19.我的胃口改變。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
20.我不易入睡或睡不穩。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
21.我曾頭痛。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
22.我覺得很好。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
23.我覺得情緒不穩。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
24.我覺得沒有精神	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
25.我覺得焦慮	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
26.我曾經胃部不適	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
27.我曾經過於急躁	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
28.我曾經覺得挫敗	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
29.我曾經生氣	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
30.我能勝任工作	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
31.我曾經覺得無助	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
32.執行護理工作感覺很好	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
33.行事為人自覺很好	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
34.我能開朗、坦誠地表達感情	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
35.我曾經覺得孤獨	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
36.我曾經覺得疲憊	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
37.我曾經覺得神經緊繃	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
38.我的家（房間）需清理而未清理。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
39.我需要時間與家人及朋友相處。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

40.我的衣服需要洗而未洗	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
41.我的物品待購而未購。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
42.我已經完成想做的護理工作。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
43.我能完成必要的護理工作。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
44.我不易找到時間參加社交活動。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
45.我能完成自己預期的護理工作。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
46.在個人生活中，我能夠說出自己的感覺，並得到需要的支持。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
47.無力完成自己日常或預期應盡責任。	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

第三部份：情緒勞動量表，請詳細閱讀題目後，依照您在面對病人或家屬時，在各種情緒管理上所付出心力的程度，○圈選相對應的數字，1 分為耗費的心力很小，7 分為為耗費的心力很大。

題目	評分程度
1. 必須做一些事，讓病人覺得自己是被尊重的。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
2.應該利用表情、態度、語調或行為來營造一種讓病人感到安心信賴的氣氛。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
3.與病人接觸時，應該主動向病人打招呼，讓病人覺得來這裡是受歡迎的。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
4.與病人交談時，應該保持親切愉快的語氣。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
5.面對病人時，臉上應該時時保持親切的笑容。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
6.工作時，醫院會要求您不讓私人感情影響您對病人的態度。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
7.在工作崗位上，醫院希望您每天都能夠保持快樂的心情，來創造工作場所歡樂的氣氛。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

8.在工作時，醫院會要求您必須表現出特定的行為或臉部表情，來傳達醫院所欲建立的特殊形象。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
9. 從事此份工作至今，醫院曾明白告知您的服務態度與笑容是醫院招來病人的重要資產。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
10.醫院會以您在服務過程中的情緒表達作為績效考核的參考依據。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
11.您的工作必須與病人直接面對面或在電話上以聲音接觸。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
12.整體而言，醫院會要求您每天接觸到相同病人的時間是相當長的。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
13.整體而言，醫院要求您每天接觸到不同病人的頻率是相當多的。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
14.在工作時，醫院會要求您根據病人的多寡或工作場所的氣氛做出不同的情緒回應，使病人會有來本院看病的欲望。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
15.當您在面對不同病人時，醫院會要求您做出不同的情緒表現。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
16.醫院會要求您對不同階層的病人做出不同的情緒反應。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
17.醫院會要求您在執行工作時，表達超出一種以上不同的情緒狀態。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
18.當病人有無理的要求，而您無法滿足或必須拒絕他們的要求時，醫院會要求您仍能保持親切和善的態度。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
19.當場面變得難以控制時，醫院會希望您即使在採取所有必要的措施來預防不幸的發生時，仍能維持和善、親切的態度。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
20.在服務過程中，即使明知病人是無理的，醫院仍會要求您站在病人的立場為病人設想。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
21.在執行任務時，即使自己情緒狀態不佳，仍應盡力克服以引導或帶給病人較佳的感受。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

22.當病人有醫院無法做到的特殊要求時，即使您很同情他，並且有想成全他的念頭時，醫院仍會希望您必須委婉拒絕病人的請求。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
23.做這份工作時，醫院會要求您表現一些與自己真實感覺不同的情緒。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
24.在工作時，儘管您已非常疲憊，醫院能會要求您必須極力表持冷靜、鎮定。	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

第四部份：工作滿意度量表，請詳細閱讀題目後，依照您個人認為的滿意度進行填答，○圈選相對應的數字，1分非常不滿意，5分為非常滿意。

題目	評分程度
1.我對於機構提供的個人防護設施及配備感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
2.我對於各項作業的資訊化感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
3.我對於工作環境的安全性感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
4.我對於機構提供醫療設備的品項及數量感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
5.我對於機構提供病人的照護模式感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
6.我對於機構支持護理師進修感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
7.我對於機構提供的專業訓練感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
8.我對於服務機構的退休制度感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
9.我對於職位的升遷機會感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
10.我對於現有的薪資報酬感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
11.我對於能自我掌握工作的狀況感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
12.我對於自己處理危機的能力感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
13.我對於工作的專業自主感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5

14.我對於自己有參與各項重要決策的機會感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
15.我對於自己的工作能力能獲得同儕的認同與肯定感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
16.我對於自己的工作能力能獲得主管的認同與肯定感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
17.我對於能從工作上獲得成就感感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
18.我對於在工作上能得到學習的機會感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
19.我對於與其他醫事人員的互動情形感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
20.我對於與醫師共同合作情形感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
21.我對於與護理師共同合作情形感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
22.我對於與行政人員的互動情形感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
23.我對於我的工作受到跨團隊成員的相互尊重感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
24.我對於與護理同儕的互動情形感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
25.我對於直屬護理主管的支持與關懷感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
26.我對於直屬護理主管的領導能力感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
27.我對於直屬護理主管有能力凝聚團隊向心力感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
28.我對於直屬護理主管能公平與合理的對待感到 (如：升遷、考核、獎勵及福利等)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
29.我對於目前非護理專業的工作量感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
30.我對於目前護理專業的工作量感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5
31.我對於自己承擔目前護理工作的困難度感到	1 - 2 - 3 - 4 - 5

再次感謝您對本研究的支持，請確保每一題皆有填答!

附錄三 人體試驗委員會同意書

新重



國軍高雄總醫院 人體試驗委員會

計畫同意函

計畫名稱：探討血液透析護理師其工作壓力、情緒勞動與工作滿意度之相關性-
以屏東市地區血液透析室為例

委員會編號：KAFGHIRB 113-060

試驗主持人：吳欣芸

計畫書版本/日期：V1/114 年 1 月 22 日

受訪者同意書版本/日期：V1/114 年 1 月 22 日

審查通過日期：民國 114 年 1 月 22 日

研究起迄期間：民國 114 年 1 月 22 日 至 民國 114 年 12 月 31 日

同意函核准起迄期間：民國 114 年 1 月 22 日 至 民國 114 年 12 月 31 日

附加建議：無

試驗機構：美和科技大學護理系健康照護

試驗進行時請依本審查會核定之計畫書、受試者同意書執行。依照法規、臨床試驗每屆滿核准期限，人體試驗委員會必須重新審查是否繼續進行。請於核准期限到期二個月前繳交期中報告以利本會進行審查。試驗完成後，應主動繳交結案報告。若試驗因故終止，也應主動繳交終止計畫報告。若有任何部分須修改，請向本審查會提出計畫變更案申請，經審查同意後始得繼續進行。

提醒事項：

1. 本計畫預定收案日期至 114 年 12 月 31 日為止，過此日期請勿收案。
2. 若需延長收案時間，請務必於 114 年 10 月 30 日前提交變更案及期中報告。

國軍高雄總醫院人體試驗委員會
主任委員

王 42 証



(802) 高雄市苓雅區中正一路 2 號
電話：(07) 7491056
E-mail：802irb@gmail.com

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 2 4 日